

식치(食治)와 체질식이요법에 대한 문헌고찰

김 종 덕*

문헌고찰을 통하여 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

첫째, 중국에서는 식치(食治)의 중요성을 예전부터 인식하여 식의(食醫)를 제도적으로 만들었고, 우리나라에서도 이를 인식하여 식의(食醫)제도가 있었다. 음식섭생으로 정(精)을 기르는 것을 중시하였으며, 약재를 사용하여 질병의 상당부분을 치료하지만, 치료하고 남은 나머지 질병은 음식으로 다스렸다.

둘째, 사상의학에서 편소지장(偏小之臟)의 본상지기(本常之氣)에 따라 명맥(命脈)이 결정되지므로, 편소지장(偏小之臟)을 생식(生息)하고 충보(充補)하는 것이 중요하다. 본상지기(本常之氣)를 회복하는데 있어서 약의 기운에 의존하지 말고 장(臟)의 기운을 북돋는데 중점을 두어야 한다. 또한 본상지기(本常之氣)를 유지하기 위해 음식을 먹지만 과식하지 말아야 한다.

셋째, 넓은 의미에서는 사상식품은 사상약물에 포함되지만 좁은 의미로는 사상식품과 사상약물은 서로 다르다. 편소지장(偏小之臟)의 본상지기(本常之氣)를 해칠 수 있는 것이 사상약물이며, 본상지기(本常之氣)를 해치지 않고 오히려 자양하는 것이 사상식품이다. 또한 약물과 식품의 차이는 맛과 식감의 유무이고, 성질이 부드럽고 강함의 차이와 장복(長服)과 단복(短服)이다. 그리고 부작용의 정도차이가 있다. 그러나 약물과 식품을 정확하게 구분하기 어렵고 이를 혼용하여 사용하기도 한다.

넷째, 사상식품 분류기준을 정리하면 다음과 같다.

태양인은 편소지장인 간(肝)의 본상지기(本常之氣)를 도와주는 간약(肝藥)이 좋다. 액(液)이 많은 메밀 포도 모과 등이 이에 속하며, 기액지기(氣液之氣)를 흡(吸)하는 것이다. 그리고 합(闔) 색력(塞力) 고중(固中) 속(束) 등으로 그 속성을 표현하기도 하였다. 태양인의 금기는 조양(助陽, 양기를 돕음)하는 약과 상초(上焦)에 작용하는 약제이다.

소양인은 편소지장인 신(腎)의 본상지기(本常之氣)를 도와주는 신약(腎藥)이 좋다. 미

* 사당한의원

(味)가 많은 황백 목통 산수유 등이 이에 속하며, 수곡지기(水穀之氣)를 출(出)하는 것이다. 그리고 강력(降力) 청장(淸腸) 등으로 그 속성을 표현하기도 하였다. 소양인의 금기는 보기(補氣)하는 약과 소도(消導)시키는 약재이다.

태음인은 편소지장인 폐(肺)의 본상지기(本常之氣)를 도와주는 폐약(肺藥)이 좋다. 형(馨)이 많은 맥문동 오미자 석창포 등이 이에 속하며, 기액지기(氣液之氣)를 호(呼)하는 것이다. 개(開) 통력(通力) 통외(通外) 완(緩) 등으로 그 속성을 표현하기도 하였다. 태음인의 금기는 온열(溫熱)한 약재와 설사시키는 약[眞墮之味]이다.

소음인은 편소지장인 비(脾)의 본상지기(本常之氣)를 도와주는 비약(脾藥)이 좋다. 취(臭)가 많은 관계 부자 백출 당귀 등이 이에 속하며, 수곡지기(水穀之氣)를 납(納)하는 것이다. 승력(升力) 온리(溫裏) 등으로 그 속성을 표현하기도 하였다. 소음인의 금기는 보음(補陰)하는 약과 하초(下焦)에 작용하는 약재이다.

다섯째, 생명[命]을 유지하고 보존하는[保] 주된[主] 기운인 보명지주(保命之主)는 태양인에게는 흡취지기(吸聚之氣), 소양인에게는 음청지기(陰淸之氣), 태음인에게는 호산지기(呼散之氣), 소음인에게는 양난지기(陽煖之氣)이다.

여섯째, 사기(四氣, 寒熱溫涼)와 오미(五味, 酸 苦 甘 辛 鹹의 5가지 맛)로 식품을 분류하는 기준방법은 1차원에 해당되어 수곡지기를 중시하는 소양인약과 소음인약을 해석하는데 유리하나 기액지기를 중시하는 태양인약과 태음인약을 해석하는데 한계가 있다. 이에 한열의 편차를 중시하는 수곡지기대사와 발산과 수렴을 중시하는 기액지기대사를 동시에 고려하는 2차원의 관점으로 식품을 보아야 한다. 따라서 열(熱)이 많은 식품이지만 발산(發散)하는 기운[熱中緩]과, 수렴(收斂)하는 기운[熱中束]이 있으며, 차가운[寒] 성질이 많은 식품이지만 발산(發散)하는 기운[寒中緩]과, 수렴(收斂)하는 기운[寒中束]이 있다. 또한 발산하는 성질이 강하지만 서늘한 기운이 있는 식품[開中涼]과 따뜻한 기운[開中溫]이 있는 식품이 있으며, 수렴하는 성질이 강하지만 서늘한 기운[闔中涼]이 있는 식품과 따뜻한 기운[闔中溫]이 있는 식품이 있다.

일곱째, 체질에 상관없이 복용할 수 있으며 크게 영향을 주지 않는 식품에서의 평(平)의 개념은 병약자(病弱者) 미병인(未病人) 건강인(健康人)에 따라 다르다고 볼 수 있으므로 같은 음식이라 하여도 건강인(健康人)이 복용하면 무난하나 병약자(病弱者)나 미병인(未病人)의 경우는 음식의 성질이 신체에 영향을 미치는 경우가 발생할 수 있다.

주제어 : 식치(食治) 체질식이요법 사상의학 본상지기(本常之氣)

I. 서론

태고 이래로 인간은 음식을 매일 먹어 왔고 앞으로도 계속 먹게 될 것이다. 예전에는 굶주림을 해결하기 위해 식품이 중요하였으나, 점차 식치(食治)로 건강한 삶을 유지하려는 흐름이 나타났고, 최근에는 개인별 체질 특징을 중시하고 질병의 치료와 예방에 도움이 되는 체질 식이요법이 중시되고 있다. 이에 전통적인 식치에 대한 이해와 사상 체질 요법에서 식품을 분류하는 기준에 대한 체계적 연구가 필요하게 되었다.

우리나라에서는 예전부터 식치의 중요성을 인식하였다. 현존하는 문헌 가운데 우리나라 최초의 식이요법서라 할 수 있는 『식료찬요(食療纂要)』(1460)에 ‘사람이 세상을 살아감에 있어서 음식이 으뜸이고 약이(藥餌)가 그 다음이다. 그러므로 고인(古人)이 처방을 내리는 데 있어서 먼저 식품으로 치료하는[食療] 것을 우선하고 식품으로 치료가 되지 않으면 약으로 치료한다고 하였으며, 식품에서 얻는 힘이 약에서 얻는 힘에 비하여 절반 이상이 된다고 하였다. 또 말하기를, 병을 치료하는 데 있어서 당연히 오곡(五穀)·오육(五肉)·오과(五果)·오채(五菜)로 다스려야지, 어찌 마른 풀과 죽은 나무의 뿌리에 치료 방법이 있을 수 있겠는가! 이것으로 고인(古人)이 병을 치료하는 데 있어서 반드시 식품으로 치료하는[食療] 것을 우선하는 이유를 알 수 있다.’¹⁾라고 하여 음식으로 먼저 치료하는[食療] 것이 질병을 치료하는 데 최우선이라고 강조하고 있다.

이처럼 식치(食治)의 중요성은 인식했으나, 개인별 체질에 따른 차이를 인식하지 못하고 누가 무엇을 먹었더니 좋았더라는 식으로 섭생하는 것이 조선 말기까지의 관행이었다. 이러한 문제점을 바탕으로 새롭게 정립한 사상의학에서는 체질에 따라 어떤 음식이 좋을 수도 있고 손해 볼 수 있다고 보았다. 비로소 본격적인 개인별 맞춤 식치가 시작된 것이다.

사상의학은 동무(東武) 이제마(李濟馬, 1837~1900)가 『동의수세보원(東醫壽世保元)』(1894)에서 주장한 학설로서, 인간을 4가지 체질(태양인·소양인·태음인·소음인)로 구분할 수 있으며, 각 체질에 따라 생리·병리·성정(性情) 등이 서로 다르므로 진단 치료 양생법을 각기 달리해야 한다는 것이다. 약 2,000여 년 전에 저술된 『영추경(靈樞經)』에 5가지 체질론이 나오고, 히포크라테스의 4가지 체액병리설 등 동서양을 막론하고 체질

1) 全循義, 『食療纂要』, 『食療纂要序』, 古人立方 先用食療 食療不愈 然後藥治 且云 將食得力 太半於藥 又曰 治病 當以五穀五肉五果五菜治之 奚在於枯草死木之根莖哉 此古人治病 必以食療爲先可知矣.

이 언급되었지만, 진정한 의미에서의 체질론은 전 세계에서 우리나라의 사상의학이 처음이라 할 수 있다.

사람은 모든 장기(臟器)의 기능이 균형을 이루어야 하지만, 체질에 따라 어떤 장기는 치우치고 어떤 장기는 부족해지는 장부 기능의 편차가 나타난다는 것이 사상의학의 체질론이다. 부족하거나 약해진 장기[偏小之臟]로 인해 질병이 나타나므로, 기능이 항진된 장기는 적당히 억제하고, 기능이 부족한 장기는 도와주어 각 장기 간의 평형이 자연스럽게 이루어지게 해야 한다. 예를 들어 태양인은 다른 장기에 비해 상대적으로 간장(肝臟)의 기능이 약해져서 수명에 영향을 준다고 본다. 같은 논리로 태음인은 폐장(肺臟), 소양인은 신장(腎臟), 소음인은 비장(脾臟)이 편소지장(偏小之臟)이므로 이 장기의 기능에 따라 수명이 좌우된다고 본다.

그러나 편소지장이 손상되어도 사람에게서는 이를 스스로 회복하고 보충하는 자연 치유 능력이 있으므로, 이 능력을 자연스럽게 도와주는 것이 매우 중요하다고 보았다. 따라서 몸이 냉해지기 쉬운 소음인은 비장이 상하기 쉬우므로 따뜻한 기운이 있는 음식이 좋으며, 열이 오르기 쉬운 소양인은 신장이 상하기 쉬우므로 시원한 기운이 있는 음식이 좋다. 반면 발산(發散)하기 쉬운 태양인은 간장이 상하기 쉬우므로 수렴 기운이 강한 음식이 좋으며, 울결(鬱結)되기 쉬운 태음인은 폐장이 상하기 쉬우니 발산 기운이 강한 음식이 좋다는 것이다.

사상의학에서 체질에 맞는 음식을 골라 먹을 것을 강조하고 있지만, 더 중요한 것은 음식을 대할 때 즐겁고 감사한 마음으로 먹는 것이다. 아무리 맛있고 몸에 좋은 음식이라 해도 기분이 나쁠 때 먹으면 소화가 되지 않고 체하는 경우를 누구나 경험한다. 반면에 거친 음식이라 하여도 친구들과 놀러 가 즐겁게 먹으면 맛도 좋고 소화가 잘되는 경우가 많다. 즉 체질에 따른 음식의 분류도 중요하지만 먹는 사람의 마음가짐에 따라 소화가 잘되어 몸에 도움이 되기도 하고, 먹은 음식으로 인해 오히려 고생하는 경우도 있다. 이처럼 편소지장의 약점을 음식으로 보완하는 것도 중요하지만, 평소 마음을 청정하게 다스리고 주색(酒色)을 멀리하며 규칙적으로 생활하는 양생(養生)이 더 중요하다고 본다. 하찮은 음식 재료라도 정성스럽게 요리하고 정갈한 그릇에 분위기 있게 상을 차리면 식욕이 동하지만, 아무리 좋은 음식이라도 성의 없이 대충 차린다면 먹고 싶은 생각이 사라질 것이다. 즉 음식을 먹을 때 미각도 중요하지만, 시각·후각·분위기 등도 소화 기능에 상당 부분 작용한다.

일반적으로 체질식이요법을 할 때 어떤 음식은 나에게 좋고 어떤 음식은 나쁘다는

강박관념으로 행한다면 몸이 경직되어 오히려 손해를 보는 경우가 많다. 따라서 자신의 체질에 맞추어 음식을 먹되 강박관념을 갖지 않고 골고루 즐겁게 먹는 것이 더 중요하다. 예를 들면, 사상의학에서는 마늘이 소음인에게 좋다고 분류하고 있는데, 우리나라 음식에는 거의 마늘이 들어간다. 이런 상황에서 소음인을 제외한 다른 체질은 마늘이 들어간 음식을 먹지 말라고 할 수 있을까. 체질과 상관없이 마늘이 들어간 음식을 즐기되, 소음인의 경우 이질 설사가 있거나 정력이 떨어질 때 마늘을 별도로 먹으면 좋은 효과를 낼 수 있다. 다른 체질의 경우에는 마늘을 과용하면 손해를 볼 수 있으므로 조심하는 태도가 중요하다.

몸이 쇠약하거나 저항력이 떨어져 한의 치료를 받을 때에는 체질에 맞추어 음식을 조절하는 것이 매우 중요하지만, 몸이 건강할 때에는 체질에 구애받지 않고 음식을 즐겁게 먹는 것이 중요하다. 예를 들어, 건강하고 젊을 때는 찬물로 목욕해도 감기에 걸리지 않고 피부가 단련되지만, 노쇠하거나 질병을 앓는 경우에 찬 곳에서 지내거나 냉수마찰을 한다면 오히려 한기(寒氣)에 몸이 더 약해질 것이다. 자신의 몸 상태에 맞추어 건강을 관리하는 것이 필요하듯이 자신의 체질에 맞춘 식이요법을 적절히 활용하는 것이 좋다.

II. 본 론

1. 식치(食治)에 대한 이해

1) 식의(食醫)의 역사

동양에서는 음식의 중요성을 예전부터 인식하여 식의(食醫) 제도를 두었다. 『주례구해(周禮句解)』에 의하면 ‘식의(食醫)가 2명이 있는데 음식을 제때에 섭취하지 못하면 질병에 걸리므로 식의를 둔 것이다.’²⁾라고 하였다. 원문에는 ‘식의(食醫)’가 아니라 ‘사의(食醫)’로 발음하라고 되어 있으나 여기에서는 관례상 ‘식의(食醫)’로 표기하였다.

식을 둔 이유에 대해 『주례집설(周禮集說)』에서는 좀 더 자세하게, ‘식의(食醫)는 임금의 음식이 조화가 맞는지 전담하였다. 『주역』에 군자는 음식을 절도 있게 먹는다고 하였듯이 대개 질병의 시작은 기(氣)와 몸의 부조화에 근본을 두고 있기 때문에 음식에

2) 朱申, 『周禮句解』, 食醫 中士二人 恐飲食失節 以致疾 故有食醫 食音嗣下同

절도가 없을 때 나타난다. 대개 음식은 사람의 근본이 되니 근본이 잘 양생되면 잘 자라지 않는 것이 없고 근본이 잘 양생되지 않으면 소멸하지 않는 것이 없다. 병이 없을 때 순응하여 잘 섭생하면 질병이 어찌 올 수 있겠는가! 이 때문에 식의라는 제도가 설치된 까닭이다.’³⁾라고 하여 평소 음식을 잘 섭취하여 질병이 나지 않도록 섭생하는 것이 매우 중요하기 때문에 식의 제도를 둔 것이라고 하였다. 즉 병이 나기 전에 음식을 잘 섭취하여 평상시의 건강을 유지할 것을 강조하였다.

우리나라에서도 식의 제도를 두었다. 조선 태조(太祖) 1년(1392) 문무백관의 관제를 정하면서 ‘내선(內膳)을 공상(供上)하는 일을 관장하는 사膳서(司膳署)를 두었고, 영(令) 1명 종5품이고, 승(丞) 2명 종6품이고, 직장(直長) 2명 종7품이고, 식의(食醫) 2명 정9품이고, 사리(司吏) 2명인데, 권무(權務)로서 거관하게 된다.’⁴⁾라고 하여 제도적으로 식치(食治)를 담당하는 식의를 두어 음식을 관리하였다.

조선 세조의 8가지 의원에 대한 의견은 매우 유명한 이야기인데 그 중에 식의가 나온다. 이를 살펴보면 ‘8종류의 의원(醫員)은 무엇을 말하는 것인가. 첫째가 심의(心醫)요, 둘째가 식의(食醫)요, 셋째가 약의(藥醫)요, 넷째가 혼의(昏醫)요, 다섯째가 광의(狂醫)요, 여섯째가 망의(妄醫)요, 일곱째가 사의(詐醫)요, 여덟째가 살의(殺醫)이다. 심의(心醫)는 사람으로 하여금 항상 마음을 편안하도록 하고 병자(病者)가 그 마음을 함부로 움직이지 않도록 하여 위태할 때에도 진실로 큰 해(害)가 없게 하고, 반드시 그 원하는 것을 꼭진히 따르게 한다. 마음이 편안하면 기운이 편안하기 때문이다. 그러나 병자와 더불어 술을 같이 마시고 깨어나지 않은 자가 있다면 이는 심의(心醫)가 아니다. 식의(食醫)는 입[口]으로 음식을 맛있게 먹을 수 있게 한다. 입이 달면(음식을 맛있게 먹으면) 기운이 편안하고, 입이 쓰면(음식을 맛없게 먹으면) 몸이 괴로워지는 것이다. 음식에도 차고 더운 것이 있으므로 증상에 맞추어 치료할 수 있으니(질병의 한열에 맞추어 음식의 한열을 이용할 수 있다.) 어찌 쓰고 매운 마른 풀이나 썩은 뿌리에 의지하겠는가!(건조된 약재보다 신선한 음식으로 치료가 가능하다.) 과식을 금지하지 않는 자가 있는데 이것은 식의가 아니다.’⁵⁾라고 하였다. 세조가 주장하는 식의는 음식을 맛있게 먹게 하여 몸을 좋게 하는 것

3) 紀昀, 『周禮集說』, 食醫 中士二人 雜說食醫專和王食 王氏曰 易之頤君子以節飲食 蓋疾病之起本於氣體之不和 始於飲食之不節 蓋飲食 人之本也 本得其養 無物不長 本失其養 無物不消 於無事之時 而順適之有道 疾病何自至哉 此食醫所以設也

4) 『朝鮮王朝實錄』, 『太祖 1년(1392) 7월 28日(丁未)』, 司膳署. 掌內膳供上之事 令一 從五品 丞二 從六品 直長二 從七品 食醫二 正九品 司吏二 權務去官

5) 『朝鮮王朝實錄』, 『世祖 9年(1463) 12월 27日(辛亥)』, 何謂八種之醫. 一者心醫 二者食醫 三者藥

으로, 무조건 단맛 나는 음식을 주는 것이 아니다.

2) 식치(食治)의 중요성

예부터 음식 섭생의 중요성을 매우 강조하였다. 『주례주소(周禮注疏)』에서는 ‘오미(五味) · 오곡(五穀) · 오약(五藥)으로 질병을 다스린다.’⁶⁾라고 하였다. 참고로, 여기에서 말하는 오미(五味)는 식초[醢] · 술[酒] · 엿[飴] · 꿀[蜜] · 생강[薑] · 소금[鹽] 5가지로 보기도 하고,⁷⁾ 신맛[酸] · 쓴맛[苦] · 단맛[甘] · 매운맛[辛] · 짠맛[鹹] 5가지로 보기도 한다.⁸⁾ 오곡(五穀)은 참깨[麻] · 메기장[稷] · 찰기장[黍] · 보리[麥] · 콩[豆] 5가지 곡식이라고 했으나,⁹⁾ 고서에 따라 다른 종류를 열거하기도 한다. 오약(五藥)은 약으로 사용하는 풀[草] · 나무[木] · 벌레[蟲] · 돌[石] · 곡식[穀] 5가지를 의미한다.

음식이 질병을 다스리는 데 제일 중요한 이유에 대해 『주관신의(周官新義)』에서는 ‘기(氣)가 부족하면 정(精)으로 보충하고, 정(精)이 부족하면 미(味)로써 보충하는 것이니, 미(味)는 정(精)을 기르는 것이고 곡식은 형(形)을 기른다. 약(藥)은 병을 치료하는 것이니 정(精)을 기르는 것이 근본[本]이고, 형(形)을 기르는 것은 그다음이고, 병을 치료하는 것은 말(末)이 된다. 이것이 치료의 순서이다.’¹⁰⁾라고 하여 오미(五味)로 정(精)을 기르고, 오곡(五穀)으로 형(形)을 기르는 것이 제일 중요하고, 오약(五藥)으로 병을 치료하는 것은 제일 말단이 된다고 하였다. 즉 음식 섭생으로 정(精)을 기르는 것이 기본이라고 강조하였다.

이와 같이 음식으로 섭생하는 것을 예전부터 매우 중시하였다. 『황제내경소문(黃帝內經素問)』에 의하면 ‘황제가 말하기를, 유독(有毒)한 약재와 무독(無毒)한 약재를 복용하는 데 제약[約]이 있습니까? 기백(岐伯)이 말하기를, 병에는 오래된 것과 새로운 것이 있고, 처방에는 대방(大方: 약재의 작용이 세고 가짓수와 용량이 많음)과 소방(小方: 약재의 작용이 약하고 가짓수와 용량이 적음)이 있으며, 약재에는 유독(有毒)한 것과 무독

醫 四者昏醫 五者狂醫 六者妄醫 七者詐醫 八者殺醫. 心醫者 教人常使心安 病者勿動其心 殆時苟無大害 必曲從其願 心安則氣安故也 有與病者對酒不醒者 此非心醫也. 食醫者 以爲口所甘食也 口甘而氣安 口苦而己苦 食有寒熱 可以對治 何籍苦辛枯草腐根 有不禁過食者 此非食醫也.

6) 『周禮注疏』, 以五味五穀五藥 養其病 注養猶治也

7) 『周禮注疏』, 五味 醢酒飴蜜薑鹽之屬

8) 董斯張, 『廣博物志』, 逆以五味五穀五藥 養其病. 五味 鹹苦酸辛甘

9) 董斯張, 『廣博物志』, 五穀 麻黍稷麥豆

『周禮注疏』, 五穀 麻黍稷麥豆也

10) 王安石, 『周官新義』, 素問曰 氣不足 補之以精 精不足 補之以味 味養精者也 穀養形者也 藥則療病者也 養精爲本 養形次之 療病爲末 此治之序也

(無毒)한 것이 있으므로 진실로 상제(常制: 항상 정해져 있는 제도)함이 마땅하다. 대독(大毒)한 약재는 질병을 치료하는 데 10중 6정도, 상독(常毒)한 약재는 질병을 치료하는 데 10중 7정도, 소독(小毒)한 약재는 질병을 치료하는 데 10중 8정도, 무독(無毒)한 약재는 질병을 치료하는 데 10중 9정도 치료되면 더 이상 주지 않아야 한다. 곡식·고기·과일·채소 등을 잘 먹고 요양하여 나머지 질병을 모두 물리친다.(약재로 질병의 대부분을 치료한 다음 나머지 질병은 음식으로 치료하고 보양하여 마무리한다.) 따라서 약재나 음식을 정도 이상으로 지나치게 사용하여 사람의 바른 기운을 상하게 하지 말아야 한다.’¹¹⁾ 라고 하여 약재에는 독성이 있으니 질병의 모든 부분을 약재로 다스리지 말고 일정 부분 치료된 뒤에는 음식으로 치료하여 정기를 보존하는 것이 중요하다고 하였다.

『유경(類經)』에서는 위에서 언급한 내용에 부연하면서 다음과 같이 약과 음식의 오남용을 경계하였다. ‘약재를 복용하는 데 제약[約]이 있는 것은 주머니를 묶는[約] 것과 같다. 주머니가 가득 찼는데 묶지 않으면 새어 나오고, 처방이 이루어졌는데 제약이 없으면 정신[神]이 없는 것과 같다. 병이 중한 사람에게는 대방(大方)이 마땅하고 병이 가벼운 사람에게는 소방(小方)이 마땅하다. 무독(無毒)한 약재는 많이 사용해야 하고 유독(有毒)한 약재는 조금 사용해야 하니 모두 절제하는 제약이 있는 것이다. 약성(藥性)에는 대독(大毒)·상독(常毒)·소독(小毒)·무독(無毒)의 구분이 있으며, 병을 제거하는 데 육분(六分)·칠분(七分)·팔분(八分)·구분(九分)의 제약이 있다. 대개 병을 치료하는 법에서 약을 질병에 비해 부족하게 사용하면 질병이 다스려지지 않고, 약을 질병에 비해 과다하게 사용하면 오히려 바른 기운을 상하게 되고 오히려 다른 질환이 생기게 된다. 따라서 당연히 제약하는 법을 알아 나아가고 그치는 데 법칙이 있어야 한다. 병이 이미 10중 8~9가 호전되었지만 남은 질병이 있는 사람은 곡식·고기·과일·채소 등의 음식으로 바른 기운[正氣]을 배양하면 나머지 사기(邪氣)는 저절로 없어진다. 독약에 제약이 있고 음식 또한 적당함이 마땅하니 지나치게 사용하지 말아야 한다. 만약 지나치게 사용하면 오히려 바른 기운을 상하게 된다.’¹²⁾

11) 王冰次注, 『黃帝內經素問』, 帝曰 有毒無毒 服有約乎 岐伯曰 病有久新 方有大小 有毒無毒 固宜常制矣 大毒治病 十去其六(下品藥毒 毒之大也) 常毒治病 十去其七(中品藥毒 次於下也) 小毒治病 十去其八(上品藥毒 毒之小也) 無毒治病 十去其九(上品中品下品 無毒藥悉謂之平) 穀肉果菜 食養盡之 無使過之 傷其正也

12) 張介賓, 『類經』, 帝曰 有毒無毒 服有約乎.(約度也 禁服篇 曰夫約方者 猶約囊也 囊滿而弗約 則輸泄 方成弗約 則神與弗俱) 岐伯 曰病有久新 方有大小 有毒無毒 固宜常制矣.(病重者宜大 病輕者宜小 無毒者 宜多 有毒者 宜少 皆常制之約也) 大毒治病 十去其六 常毒治病 十去其七 小毒治病 十去其八 無毒治病 十去其九.(藥性 有大毒常毒小毒無毒之分 去病 有六分七分八分九分之約

일반적으로 음식으로 몸을 다스리는 데 있어서 ‘오곡(五穀)으 보양하고, 오과(五果)로 도와주며, 오축(五畜)으로 힘을 북돋우며, 오채(五菜)로 보충한다. 기미(氣味)에 맞추어 복용하면 정혈(精血)을 보하고 기운을 북돋는다.’¹³⁾라고 하였다. 여기에서 언급된 오곡(五穀)은 멥쌀[粳米]·팥[小豆]·보리[麥]·콩[大豆]·찰기장[黃黍] 5가지 곡식을 의미하고, 오과(五果)는 복숭아[桃]·오얏[李]·살구[杏]·밤[栗]·대추[棗] 5가지를, 오축(五畜)은 소[牛]·양[羊]·돼지[豕]·개[犬]·닭[雞] 5가지를, 오채(五菜)는 아욱[葵]·콩잎[藿]·염교[薤]·파[葱]·부추[韭] 5가지를 의미한다.

이와 같이 음식 섭생이 중요하기에 실생활에서 다음과 같이 응용되기도 했다. 『수친양로신서(壽親養老新書)』에서는 ‘만약 질환이 생기면 먼저 식의(食醫)의 방법으로 그 증상을 살핀 다음 음식으로 치료하고, 음식으로도 치유되지 않으면 약을 쓰되 해당 장부(臟腑)를 손상시키지 말아야 한다.’¹⁴⁾라고 하였다. 해당되는 문장이 비록 노인의 경우에 해당되지만, 질환이 생기면 먼저 음식으로 치료하고, 약을 사용해도 장부에 손상이 가지 않도록 하는 정신을 읽을 수 있다. 또한 질병 치료 이후의 섭생에도 음식의 중요성을 강조하였다.

『수친양로신서』에 ‘만약 고질병이 있거나 혹은 때때로 질병이 발동(發動)하면 즉 그 증상에 따라 중화(中和)시키는 탕약(湯藥)을 3~5일 정도 쓴다. 자연스럽게 질병이 나타나지 않으면 음식으로 조정(調停)하는데, 식의의 방법에 따르고 식성에 따라 반찬을 바꾸어 치료하는 것이 가장 좋은 방법이다.’¹⁵⁾라고 하여 질병 치료 이후의 섭생은 음식으로 해야 하며, 음식을 본인의 식성에 맞추어 맛있게 먹는 것이 중요함을 강조하였다.

평소 건강관리의 중요성에 대해 『황제내경소문(黃帝內經素問)』에서는 ‘성인(聖人)은 이미 발병된 환자를 치료하는 것이 아니라 병이 나기 전에 다스리고, 세상이 어지러운 다음에 다스리는 것이 아니라 어지럽기 전에 다스리는 것을 일컫는 것이다. 병이 이미

者 蓋以治病之法 藥不及病 則無濟於事 藥過於病 則反傷其正 而生他患矣 故當知約制 而進止有度也 穀肉果菜 食養盡之 無使過之 傷其正也。(病已去其八九 而有餘未盡者 則當以穀肉果菜 飲食之類 培養正氣 而餘邪自盡矣 如藏氣法時論 曰毒藥攻邪 五穀爲養 五果爲助 五畜爲益 五菜爲充者 是也 然毒藥 雖有約制 而飲食亦貴得宜 皆不可使之太過 過則反傷其正也)

13) 王冰次注, 『黃帝內經素問』, 五穀爲養(謂粳米小豆麥大豆黃黍也) 五果爲助(謂桃李杏栗棗也) 五畜爲益(謂牛羊豕犬雞也) 五菜爲充(謂葵藿薤葱韭也) 氣味合而服之 以補精益氣

14) 陳直, 『壽親養老新書』, 若有疾患 且先詳食醫之法 審其疾狀 以食療之 食療未愈然後 命藥貴不傷其臟腑也 凡百飲食必在人子躬親調治 無縱婢使慢其所食老人之食 大抵宜其溫熱熟軟 忌其粘硬生冷

15) 陳直, 『壽親養老新書』, 若身有宿疾 或時發動 則隨其疾狀 用中和湯藥 順三朝五日 自然無事然後 調停飲食 依食醫之法 隨食性變饌治之 此最爲良也

난 다음에 약을 사용하거나 세상이 어지러운 다음에 다스리는 것은 비유하건대 갈증이 날 때 우물을 파거나 다툼이 있을 때 무기를 만드는 것과 같으니, 이 또한 너무 늦지 않겠는가!’¹⁶⁾라고 하여 질병에 걸린 후에 치료할 것이 아니라 평소 음식 섭생을 잘하여 병이 나지 않도록 예방하는 것이 중요하다고 하였다.

3) 명맥(命脉)의 중요성

73명맥(命脉)은 생명을 유지하는 근본으로, 명맥을 잘 관리하고 유지하면 장수할 수 있다. 사상의학에서는 명맥을 어떠한 관점으로 보았는지 살펴보자.

사상의학에서는 폐대간소(肺大肝小)한 사람을 태양인(太陽人), 간대폐소(肝大肺小)한 사람을 태음인(太陰人), 비대신소(脾大腎小)한 사람을 소양인(少陽人), 신대비소(腎大脾小)한 사람을 소음인(少陰人)이라고 정의하고 있다.¹⁷⁾ 사상인의 질병은 각 체질의 편소지장으로 인해 나타난다고 보았다. 즉 ‘태양인의 주색재권(酒色財權)에서 모든 내상(內傷)과 외감(外感)으로 인한 피해는 모두 간(肝)을 손상시키기 때문에 태양인은 간장(肝臟)의 기운이 넘치고 적음이 명맥(命脉)의 길고 짧음이 된다. 태음인의 주색재권에서 모든 내상과 외감으로 인한 피해는 모두 폐장(肺臟)을 손상시키기 때문에 태음인은 폐장의 기운이 넘치고 적음이 명맥의 길고 짧음이 된다. 마찬가지로 소양인은 신장(腎臟), 소음인은 비장(脾臟)의 기운이 명맥의 길고 짧음이 된다.’¹⁸⁾고 하여 각 체질의 편소지장에 의해 명맥이 결정된다고 하였다. 그러면 편소지장(偏小之藏)과 편대지장(偏大之藏)이 어느 정도 편차를 보여야 질병의 단계가 될까?

이에 대해 이제마는 ‘태양인의 간장(肝臟)이 충분히 온전하고 폐(肺)와 비교하여 서로 대적할 수 있는 자는 지극히 완전한 경지의 사람이고, 간장이 절반 정도 소모되고 모자라서 폐와 비교하여 2배 정도 약한 자는 극히 파괴된 지경의 사람이다. 이것을 초과하면 죽는다. 이로 미루어 볼 때 태양인은 간장의 절반이 명맥을 이어 가는 실수(實數)가

16) 王冰次注, 『黃帝內經素問』, 聖人不治已病治未病 不治已亂治未亂 此之謂也 夫病已成而後藥之 亂已成而後治之 譬猶渴而穿井 鬥而鑄錐 不亦晚乎

17) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 人稟臟理 有四不同 肺大而肝小者 名曰太陽人 肝大而肺小者 名曰太陰人 脾大而腎小者 名曰少陽人 腎大而脾小者 名曰少陰人.

18) 李濟馬, 『四象草本卷』, 太陽人 財權酒色 凡百內傷外觸 皆損肝 故太陽人 以肝臟剩削 爲命脉長短 太陰人 財權酒色 凡百內傷外觸 皆損肺 故太陰人 以肺臟剩削 爲命脉長短 少陽人 財權酒色 凡百內傷外觸 皆損腎 故少陽人 以腎臟剩削 爲命脉長短 少陰人 財權酒色 凡百內傷外觸 皆損脾 故少陰人 以脾臟剩削 爲命脉長短.

된다. 다른 장부도 이와 같다.’¹⁹⁾고 하여, 명맥의 실수는 사상인의 편소지장의 기운이 온전하여 편대지장에 비하여 대적할 정도면 건강한 사람이지만, 편소지장의 기운이 절반 정도 훼손되어 편대지장에 비해 반밖에 되지 않으면 목숨이 극히 위험한 사람이라고 하였다.

그러면 편소지장이 약해졌을 때 어떻게 이를 회복할 수 있을까? 이에 대해 ‘명맥이 비록 손상을 입었다 해도 64세 이전에는 대개 생식(生息: 살아 숨을 쉬)하고 충보(充補: 보충)하는 이치가 있어 회복된다. 그러나 노년(老年)은 장년(壯年)만 같지 못하고, 소년(少年)은 유년(幼年)만 같지 못하다. 소년의 생식은 유년의 3/4이고, 장년의 생식은 유년의 2/4이고, 노년의 생식은 유년의 1/4이 되는 고로 평인(平人: 병이 없는 사람)은 40세가 중년(中年)이 되고, 극수인(極壽人: 오래 사는 사람)은 60세가 중년이 된다.’²⁰⁾라고 하여 자연 치유 능력인 생식하고 충보하는 이치가 있어 몸이 회복되지만 젊은 사람의 회복력이 더 좋다고 보았다. 또한 중년(中年)의 개념이 절대적인 나이가 아니라 건강인과 비건강인에 따라 달라질 수 있다고 하였다. 그리고 명맥을 유지하기 위해서 자연 치유 능력을 함양해야 하는데 평소 음식 섭생에 따라 좌우된다고 보았다. 참고로 여기에서 말한 ‘생식(生息)’이란 생명을 번식시켜 삶을 유지시키는 근본이 되는데 이를 도와주기 위해 체질별 정기(正己: 자기 자신을 바르게 함)를 중시하였다.

4) 본상지기(本常之氣)의 중요성

편소지장의 본래의 기운을 되살리기 위해 한약을 사용할 때 일정한 규칙이 있다. 이에 대해 ‘인삼·복령·구기자·감국 등은 성질이 담백하고 평(平)하여 질병이 있을 때 오랫동안 상복할 수 있다. 하지만 약을 먹는 도중 틈틈이 중지하여 장(臟) 본래의 기운을 편안히 해야 한다.’²¹⁾고 하여 상복할 수 있는 약이라 하여도 편소지장의 본상지기(本常之氣: 본래의 기운)를 어떻게 유지하느냐에 기준을 두어 계속 약에만 의존하는 것을 경계하였다.

그러나 약을 먹는 데 있어서도 ‘벽에 흙을 바를 때 객토(客土: 외부에서 가져온 흙)와 주토(主土: 본래의 흙)가 완전히 합쳐지지 않으면 수삼(數三: 2~4)월 이후에 객토와 주토가 모두 떨어진다. 장(臟)을 보하는 약의 기운과 장의 기운이 완전히 합쳐지지 않으면

19) 李濟馬, 『四象草本卷』, 太陽人肝臟 十分圖全 而與肺相敵者 極完境人也 一半虧缺 而與肺讓倍者 極壞境人也 過此則死 以此推之 太陽人肝臟部一半 爲命脉實數 他臟倣此.

20) 李濟馬, 『四象草本卷』, 命脉 雖間有損傷 六十四歲前 皆有生息充補之道 但老年不如壯年 少年不如幼年 少年生息 得幼年四分之三 壯年生息 得幼年四分之二 老年生息 得幼年四分之一 故平人以四十歲爲中年 極壽人以六十歲爲中年.

21) 李濟馬, 『四象草本卷』, 蔘苓杞菊等藥 性淡平 有病可以久服常服 而亦有時間斷 以安臟本常之氣.

면 반 년 후에 약의 기운과 장의 기운이 모두 고갈되게 된다. 따라서 준보(峻補: 강하게 보함)하는 경분(輕粉)·인삼·녹용 등의 약을 여러 번 사용하지 말아야 한다. 만약 준보하는 약을 먹은 사람은 1~2년 간 더욱 지극하게 몸을 섭생하여 약의 기운과 장의 기운이 완전히 합쳐지기를 기다린 연후에 근심이 없게 된다. 화(禍)는 태만한 데서 생기며 병(病)은 약간 치유된 사람에게 더 심하게 된다는 것은 바로 이것을 말하는 것이 아니겠는가!’²²⁾라고 하여 약에만 의존하지 말고 장의 기운을 위주로 조화를 맞추는 것이 중요하다고 하였다. 이렇게 하기 위하여 마음을 청정하게 다스리고 주색(酒色)을 멀리하면 약의 기운과 장의 기운이 서로 보존되지만, 그렇지 않으면 몸을 보하는 약이 오히려 병을 키울 것이라고 하였다.²³⁾

따라서 ‘장(臟)의 기운이 주(主)가 되고 약의 기운은 객(客)이 된다. 장(臟)의 기운이 3배이고 약의 기운이 1배이면 그 병은 즉시 달아나고(치유되고), 장(臟)의 기운이 2배이고 약의 기운이 1배이면 약의 기운이 쉽게 도달하고, 장(臟)의 기운과 약의 기운이 서로 비슷하면 이기고 지는 것을 알 수 없다. 장의 기운과 약의 기운이 서로 싸우면[對敵] 오히려 약으로 인해 몸이 상하게 된다. 이런 까닭으로 소양인에게 수은(水銀)을 가볍게 사용하지 말아야 하고, 소음인에게 인삼(人蔘)과 부자(附子)를 자주 사용하지 말아야 한다.’²⁴⁾라고 하여 약의 기운에 의존하지 말고 본래 기운인 장의 기운에 더 중점을 두어야 한다고 하였다. 즉 체질에 맞는 약이라 하여도 약의 기운을 받아들이는 장부의 상태에 따라 조절해야 하는데, 체질에 맞지 않는 약을 사용할 때의 피해는 이로 미루어 짐작할 수 있다.

이처럼 장의 기운을 중시하였는데 ‘태양인의 병에 태양인 약을 투여하였으나 병세가 좋아지기는커녕 더욱 심해지기만 하면 장의 기운[臟氣]이 이미 고갈된 것이므로 그 병은 치료되지 않는다. 태음인·소양인·소음인도 이와 같다.’²⁵⁾라고 하여 약물보다 그 약물을 받아들일 수 있는 신체적 조건 즉 장부의 본상지기를 유지하는 것이 중요하다고 보았다.

22) 李濟馬, 『四象草本卷』, 塗壁之客土與主土 不成完合 則數三月後 客土與主土俱落 補臟之藥氣與臟氣 不成完合 則一半年後 藥氣與臟氣具渴 故峻補輕粉參茸等藥 不可屢用 用之者 一二年間 尤極攝身 期于藥氣與臟氣完合 然後保無虞 禍生于所易 病加于少愈者 非此之謂乎

23) 李濟馬, 『四象草本卷』, 孟子曰 君未響道志仁 而求爲之強戰益地 是補架富桀也 孟子教以譬諭之曰 病人未清淨思慮 嚴禁酒色 而求爲常法 補藥益氣 是補病富病也.

24) 李濟馬, 『四象草本卷』, 臟氣主也 藥氣客也 臟氣三倍 而藥氣一倍 則其病即遁也 臟氣二倍 而藥氣一倍 則藥力易達也 臟氣與藥氣相敵 則勝負之數 未可知也 臟氣與藥氣對敵 則倒戈之變 可立待也 所以少陽之水銀 不可以輕用 少陰之參附 不可以屢用.

25) 李濟馬, 『四象草本卷』, 太陽病 以太陽藥投之 而病勢益劇 有加無減者 臟氣已渴 而其病不治 太陰少陽少陰倣此

약을 먹는 것에 대해서도 ‘성질이 평(平)하고 담백한 약은 오래 먹을 수 있고, 편벽된 약은 오래 먹을 수 없다. 병이 있는 사람은 약을 먹어도 되지만, 병이 없는 사람은 약을 먹지 말아야 한다.’²⁶⁾라고 하여 거친 약보다는 부드러운 약을 사용하고, 질병이 있을 때만 약을 먹으라고 하였다. 이와 같이 본상지기를 유지하는 데 있어서 약보다는 평소 섭취하는 음식으로 조절함이 더 중요하다. 따라서 식품은 대체로 성질이 평하고 담백하므로 본상지기를 유지할 수 있지만, 약물은 질병을 치료하기 위해 투여하는 것으로 본상지기의 손상이 없는 한도에서 사용해야 한다고 하였다.

본상지기를 유지하려면 음식을 먹을 때 지나치게 배부르게 먹지 말아야 한다. ‘아침에 먹은 것이 낮에 소화되면 먹은 것이 편안해지고, 때로 배고프고 때로 배부르면 위기(胃氣)가 편안해진 것이니 이것은 음양지도(陰陽之道)이다. 낮과 밤[陰과 陽]으로 비유하면, 좋은 음식을 항상 배부르게 먹으면 양(陽)만 있고 음(陰)이 없으며, 보약으로 항상 보하면 낮만 있고 밤이 없는 것과 같다. 따라서 병이 있는 사람은 약을 먹지만 병이 없는 사람은 약을 먹어서는 안 된다. 오곡(五穀)의 성질이 담백하여도 항상 배부르게 먹으면 해가 되거늘 하물며 약은 어떻겠는가? 비유하건대 겨울에 항상 따뜻하게 배불리 먹고 더욱 그렇게만 하려는 자는 신체가 따뜻하고 배부른 것에만 습관이 되어서 추위를 이겨 내지 못하니 사람의 장위(腸胃)도 이와 같은 것이다.’²⁷⁾라고 하여 음식을 먹는 데도 조절이 필요하듯 약을 장기간 함부로 복용하는 것을 조심해야 한다고 하였다.

5) 약물과 식품의 차이

사상의학에서는 약물을 체질에 맞추어 태음인 약[肺藥]·소음인 약[脾藥]·태양인 약[肝藥]·소양인 약[腎藥]으로 구분하고, 식품을 태음인 식품·소음인 식품·태양인 식품·소양인 식품으로 구분하고 있다. 그런데 넓은 의미에서 사상식품은 모두 사상약물에 해당된다고 할 수 있다. 즉 넓은 의미로 보면 사람이 복용하는 모든 것이 사상약물에 해당된다. 사상약물 가운데 기가 편벽된 것과 평(平)한 것의 차이가 있으며, 단기간 복용해야 하는 것과 장기간 복용할 수 있는 것의 차이가 있다.

반면 좁은 의미로 보면 사상식품은 사상약물에 포함되지 않으며, 본상지기를 기르는

26) 李濟馬, 『四象草本卷』, 平淡之藥 可以久服 偏僻之藥 不可以久服 有病之人 可以服藥 無病之人 不可以服藥.

27) 李濟馬, 『四象草本卷』, 朝食晝化 則食其安矣 時飢時飽 則胃氣安矣 以陰陽之道也 晝夜之像 梁肉常飽 則陽而無陰也 補藥常補 則晝而無夜也 是故 有病者 可以服藥 無病者 不可以服藥 五穀之性淡 平常飽 則有害 況藥乎 譬如 冬日溫飽益厚者 身體習慣溫飽 益不耐寒 人之腸胃 亦如此

데 바탕이 된다. 따라서 사상약물과 사상식품과의 차이를 다음과 같이 볼 수 있다.

첫째, 사상약물은 넓은 의미와 좁은 의미로 각각 볼 수 있다. 넓은 의미의 사상약물은 사상식품을 포함한 개념이며, 좁은 의미의 사상약물은 사상식품과 서로 대비되는 개념이다.

둘째, 좁은 의미의 사상약물은 사상인의 편소지장을 보완하여 명맥을 유지하지만, 본상지기를 해칠 수도 있어 장기 복용이 어렵다. 반면 사상식품은 사상약물에 비해 기가 편벽되지 않으므로 장기간 복용이 가능하고 본상지기를 자양할 수 있다.

일반적으로 약물과 식품의 차이는 분명 있지만 그 경계선이 애매모호하므로 어떤 기준으로 볼 것이냐가 문제가 된다. 약물과 식품의 구별에 있어서 여러 가지 설명이 있을 수 있으나 다음과 같은 기준으로 보는 것이 타당하다.

첫째, 식품으로 만든 음식은 맛과 식감이 있어 상식(常食)하기 좋지만 약물은 맛과 식감이 현저히 떨어져 상식하기 어렵다. 약물은 질병이 있을 때 치료 목적으로 일시적으로 복용하는 것이 상례이다. 황기를 닭에 넣어 끓여 먹는 경우 황기를 달여 그 국물을 이용하지만 황기를 씹어 먹지는 않는다. 따라서 황기는 식품이 아니라 약물이라고 한다. 마찬가지로 콩나물은 우황청심환의 재료로 사용될 정도로 효능이 매우 좋지만 삶았을 때의 맛과 식감이 좋으므로 약물이 아니라 식품이라고 한다.

둘째, 식품은 대체적으로 성질이 부드럽고 순하여 장복이 가능하나, 약물은 성질이 강하여 장복하면 오히려 장부의 정기를 상하는 경우가 많다. 따라서 특별한 경우에 약물을 장복하기도 하나 일반적으로 질병이 호전될 때까지만 사용한다.

셋째, 약물은 체질과 증상에 따라 알맞게 사용하면 매우 좋은 효과를 내지만 잘못 사용하면 부작용이 크다. 그러나 식품은 약물에 비하여 부작용이 상대적으로 적다.

이상과 같은 기준으로 분류함에도 불구하고 약물과 식품의 구분이 어려운 경우도 있다. 예를 들면 도라지·은행·밤·율무·생강·대추·잣 등은 보는 관점에 따라 약물이 되기도 하고 식품이 되기도 한다.

2. 사상 식품 분류 방법론

사상 체질 식이요법에서 중요한 것 중의 하나가 음식을 어떠한 기준으로 분류할 것이냐 하는 것이다. 보는 관점에 따라 논란의 소지는 있으나 사상의학에서 분류하는 기준을 조목조목 살펴보자.

1) 사당론(四黨論)

사상의학에서는 수곡지기(水穀之氣: 음식물이 소화되어 생기는 정기)의 대사 경로에 따라 크게 폐비간신(肺脾肝腎)의 4가지로 나뉜다고 보고 있다. 이에 각각의 무리인 당(黨)으로 묶어 사당론(四黨論)이라는 새로운 방법론으로 접근하고 있다. 사당(四黨)으로 묶어 설명하는 것은 기존 의서에서 찾아보기 어려운 사상의학만의 독특한 방법론으로, 폐당(肺黨)에는 위완(胃脘)·혀[舌]·귀[耳]·두뇌(頭腦)·피모(皮毛: 체표의 피부에 붙어 있는 털) 등이 배속되고,²⁸⁾ 비당(脾黨)에는 위(胃)·양쪽 유방[兩乳]·눈[目]·등뼈[背脊]·근육[筋] 등이 배속되고,²⁹⁾ 간당(肝黨)에는 소장(小腸)·배꼽[臍]·코[鼻]·허리등뼈[腰脊]·살[肉] 등이 배속되고,³⁰⁾ 신당(腎黨)에는 대장(大腸)·전음(前陰: 외부 생식기 및 요도)·입[口]·방광(膀胱)·뼈[骨] 등이 배속되는 것으로 보았다.³¹⁾

비슷한 논리로, 약재와 식품을 폐비간신(肺脾肝腎)에 해당되는 약으로 분류하여 체질별 약재로 구분하였다. 동무의 초기 저작으로 알려진 『동무유고(東武遺稿)』에서 태음인 약을 폐약(肺藥), 소음인 약을 비약(脾藥), 태양인 약을 간약(肝藥), 소양인 약을 신약(腎藥)으로 분류하여 사상약성가(四象藥性歌)로 정리하고 있다. 참고로 ‘폐약(肺藥)’이라고 하면 폐(肺)에 좋은 약으로 잘못 이해하는 경우가 있으나 이는 태음인에게 좋은 약을 의미한다. 마찬가지로 비약(脾藥)·간약(肝藥)·신약(腎藥) 등도 각각 비장·간장·신장에 좋은 약으로 잘못 이해하는 경우가 많으니 유의해야 한다.

이러한 예는 소양인의 경험방인 황련저두환(黃連猪肚丸)을 설명하는 대목에서 ‘소양인 약은 신약(腎藥)이고, 태양인 약인 맥문동은 폐약(肺藥)에 속한다.’³²⁾고 언급하고 있

28) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 「臟腑論」, 水穀溫氣 自胃脘而化津 入于舌下 爲津海 津海者 津之所舍也 津海之清氣 出于耳而爲神 入于頭腦 而爲腦海 腦海者 神之所舍也 腦海之腦汁清者 內歸于肺 濁滓外歸于皮毛 故胃脘與舌耳頭腦皮毛 皆肺之黨也.

29) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 「臟腑論」, 水穀熱氣 自胃而化膏 入于臍間兩乳 爲膏海 膏海者 膏之所舍也 膏海之清氣 出于目而爲氣 入于背脊 而爲膜海 膜海者 氣之所舍也 膜海之膜汁清者 內歸于脾 濁滓 外歸于筋 故胃與兩乳目背脊筋 皆脾之黨也.

30) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 「臟腑論」, 水穀涼氣 自小腸而化油 入于臍 爲油海 油海者 油之所舍也 油海之清氣 出于鼻而爲血 入于腰脊 而爲血海 血海者 血之所舍也 血海之血汁清者 內歸于肝 濁滓 外歸于肉 故小腸與臍鼻腰脊肉 皆肝之黨也.

31) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 「臟腑論」, 水穀寒氣 自大腸而化液 入于前陰毛際之內 爲液海 液海者 液之所舍也 液海之清氣 出于口而爲精 入于膀胱 而爲精海 精海者 精之所舍也 精海之精汁清者 內歸于腎 濁滓 外歸于骨 故大腸與前陰口膀胱骨 皆腎之黨也.

32) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 「黃連猪肚丸」, 雄猪肚 一個 黃連 小麥炒 各 五兩 天花粉 白茯苓 各 四兩 麥門冬 二兩 右爲末 入猪肚中 封口 安甌中蒸 爛搗 作丸梧子大 ○此方 出於危亦林得效方

으며, 육미지황탕(六味地黃湯)을 설명하면서 태음인 약인 산약(山藥)은 폐약(肺藥)이라고 설명하고,³³⁾ 태양인 약재를 설명하면서 ‘채소와 과일 가운데 맑고 평(平)하며 소담(疏淡: 시원하고 담백함)한 약은 모두 간약(肝藥)에 속한다.’³⁴⁾라고 한 것에서 찾아볼 수 있다. 체질별 약재와 식품을 사당론에 입각하여 분류한 것이다.

그러나 사당론에 언급된 폐비간신(肺脾肝腎)은 기존 한의학의 장부 이론과 다르므로 오해하지 말아야 한다. 즉 기존 한의학에서 바라본 오행(五行: 木火土金水)과 사상의학에서 바라보는 오행(五行)이 다른데, 사상의학에서 토(土)는 다루지 않고 사실상 목화금수(木火金水)만을 언급하고 있다. 『동무유고』에 의하면 신체 부위의 상하로 폐비간신(肺脾肝腎)을 설정하고 이에 맞추어 목화금수(木火金水)로 배속하였다.³⁵⁾ 즉 폐(肺)는 목(木), 비(脾)는 화(火), 간(肝)은 금(金), 신(腎)은 수(水)로 배속하여 기존의 한의학에서 언급하고 있는 간(肝)이 목(木), 심(心)이 화(火), 비(脾)가 토(土), 간(肝)이 금(金), 신(腎)이 수(水)라고 하는 것과는 다르다.

그러면 왜 이렇게 차이가 날까? 사상의학에서 ‘폐(肺)는 능히 애(哀)가 되고 애기(衰氣)는 직승(直升)하며, 비(脾)는 능히 노(怒)가 되고 노기(怒氣)는 횡승(橫升)하며, 간(肝)은 능히 희(喜)가 되고 희기(喜氣)는 방강(放降)하며, 신(腎)은 능히 낙(樂)이 되고 낙기(樂氣)는 함강(陷降)한다.’³⁶⁾라고 한 것을 미루어 보면, 폐(肺)는 곧게 뻗어 나가는 기운이므로 오행의 입장에서 보면 목(木)에 배속되고, 비(脾)는 사방으로 펼쳐 나가는 기운이므로 화(火)에 배속되고, 간(肝)은 수렴하여 내려가는 기운이므로 금(金)에 배속되고, 신(腎)은 빠져서 확 내려가 기운이 멎쳐지므로 수(水)에 배속되는 것이다. 그러나 후에 이제 마는 기존 의학의 오행론(五行論)에 심취한 학자들의 오해(?)를 의식해서인지 말년에 저술된 『동의수세보원(東醫壽世保元)』에서는 슬그머니 오행(五行)에 대한 언급을 삭제하였다.

후대에 출간된 『보제연설(普濟演說)』에서도 <그림 1>에 보이듯이 폐(肺)는 목(木), 비(脾)는 화(火), 간(肝)은 금(金), 신(腎)은 수(水)로 배속하고 심(心)은 중앙에 놓고 오행(五行)에 배속하지 않았다. 즉 『보제연설』에서 ‘심(心)은 일신(一身)의 주인으로 천군(天君)

書中 治強中證 ○今考更定 此方中 麥門冬一味 肺藥也 肺與腎 一升一降 上下貫通 腎藥五味中 肺藥一味 雖爲贅材 亦自無妨 不必苛論

33) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 『六味地黃湯』, 熟地黃 四錢 山藥 山茱萸 各二錢 澤瀉 牡丹皮 白茯苓 各一錢五分 ○此方 出於虞博醫學正傳書中 治虛勞 ○今考更定 此方中 山藥一味 肺藥也

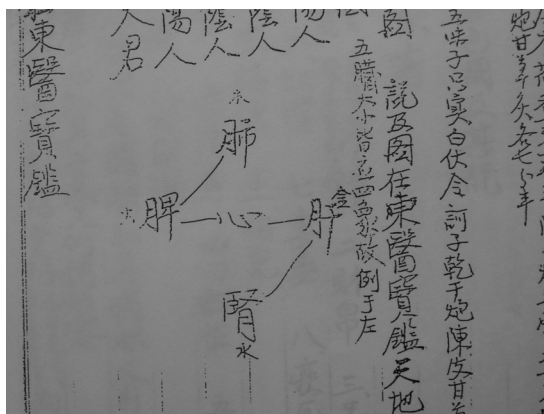
34) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 凡菜果之屬 清平疏淡之藥 皆爲肝藥 蛤屬 亦補肝.

35) 李濟馬, 『東武遺稿』, 肺屬木 脾屬火 肝屬金 腎屬水

36) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 衰氣直升 怒氣橫升 喜氣放降 樂氣陷降.

李濟馬, 『東武遺稿』, 肺能哀 脾能怒 肝能喜 腎能樂

이다.’³⁷⁾라고 하여 오행에 배속하지 않았는데, 이는 『동의수세보원(東醫壽世保元)』에서 심(心)을 중앙의 태극으로 보는 것,³⁸⁾ 그리고 심(心)을 일신(一身)의 주재(主宰)로 보는 것과³⁹⁾ 같은 개념이다. 이상을 정리하면 <표 1>과 같다.



<그림 1> 『普濟演說』에서의 木火金水 배속

<표 1> 체질별 사당론(四黨論)

체질	편대지장	오행	편소지장	체질약
태양인	肺大	木	肝小	肝藥
소양인	脾大	火	腎小	腎藥
태음인	肝大	金	肺小	肺藥
소음인	腎大	水	脾小	脾藥

2) 형취액미(馨臭液味)

체질별 약재를 분류하는 데는 여러 가지 기준이 있지만, 그중 하나가 ‘형취액미(馨臭液味)’의 방법이다. 『동무유고』에 의하면, 형(馨)은 향기가 멀리 퍼져 나가는 것을 의미

37) 『普濟演說』, 心者 一身之主 名曰天君

38) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 五臟之心 中央之太極也 五臟之肺脾肝腎 四維之四象也 中央之太極 聖人之太極 高出於衆人之太極也 四維之四象 聖人之四象 旁通於衆人之四象也.

39) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 心爲一身之主宰 負隅背心 正向臆中 光明瑩徹 耳目鼻口 無所不察 肺脾肝腎 無所不付 頤臆臍腹 無所不誠 頭手腰足 無所不敬.

하니 마치 애성(哀性)이 멀리 퍼져 나가는 것과 흡사하여 태음인 약(肺藥)에 배속되고, 취(臭)는 향기가 퍼져 나가는 것이 아니라 근처에서만 나는 것으로 마치 노성(怒性)이 널리 감싸 안는 것과 흡사하여 소음인 약(脾藥)에 배속되고, 액(液)은 흘러서 퍼지고 모이되 2차원 공간에서만 가능하므로 마치 희성(喜性)이 넓게 퍼지는[廣張] 것과 흡사하여 태양인 약(肝藥)에 배속되고, 미(味)는 씹어야 맛을 아는 것처럼 퍼지지 않고 뭉치므로 마치 낙성(樂性)이 깊이 굳어지는 것과 흡사하여 소양인 약(腎藥)에 속한다고 보았다.⁴⁰⁾ 또한 ‘약물(藥物)의 성품에서 형(馨)이 많은 것은 폐(肺)로 기운이 들어가고, 취(臭)가 많은 것은 비(脾)로 기운이 들어가고, 옥(沃)이 많은 것은 간(肝)으로 기운이 들어가고, 미(味)가 많은 것은 신(腎)으로 기운이 들어간다. 따라서 황백(黃栢)·목통(木通)·산수유(山茱萸) 등은 그 미(味)가 깊이 흡입되어 신(腎)으로 들어가고, 맥문동(麥門冬)·오미자(五味子)·석창포(石菖蒲) 등은 그 형(馨)이 가볍고 맑아[輕清] 폐(肺)로 떠오르며, 관계(官桂)·부자(附子)·백출(白朮)·당귀(當歸) 등은 그 취(臭)가 맹렬(猛烈)하여 비(脾)를 쪼ץ쪼ץ하게 하고, 메밀[蕎麥]·포도(葡萄)·모과(木瓜) 등은 그 액(液)이 연음(緣淫)하여 간(肝)을 느슨하게[緩] 한다. 이것으로 미루어 보면 모든 약초를 당연히 체질별로 알 수 있다.’⁴¹⁾라고 하여 형취액미(馨臭液味)의 기준에서 약재를 구체적으로 분류하고 있다. 다만 여기에서는 태양인 약의 기준인 액(液)을 옥(沃)으로 바꿔 표현했는데 넓은 의미로 보면 같은 의미로 해석된다. 이상을 정리하면 다음 <표 2>와 같다.

<표 2> 체질별 형취액미(馨臭液味)

체질	체질약	특성	약 물
태양인	肝藥	液 = 沃	메밀 · 포도 · 모과
소양인	腎藥	味	황백 · 목통 · 산수유
태음인	肺藥	馨	맥문동 · 오미자 · 석창포
소음인	脾藥	臭	관계 · 부자 · 백출 · 당귀

그런데 기존의 의서에 사용된 형(馨)은 향기가 퍼져 나간다는 형향(馨香), 방형(芳馨)

40) 李濟馬, 『東武遺稿』, 「總論」, 四藥之於四臟也 馨歸於肺 臭歸於脾 液歸於肝 味歸於腎.

41) 李濟馬, 『東武遺稿』, 藥物之性 厚馨者 歸於肺 厚臭者 歸於脾 厚沃者 歸於肝 厚味者 歸於腎 是故 黃栢 木通 山茱萸 等屬 其味深吸 而入於腎 麥門冬 五味子 石菖蒲等屬 其馨輕清 而浮於肺 官桂 附子 白朮 當歸等屬 其臭猛烈 而壯於脾 蕎麥 葡萄 木瓜等屬 其液緣淫 而緩於肝 以此而推 則百草可當而知之也.

의 의미로 사용되었다. 『제민요술(齊民要術)』(530~550)에서는, ‘귤수(橘樹: 귤나무)는 흰 꽃이 피며 붉은 열매가 있고 껍질은 향기가 형향(馨香)하다. 또한 맛이 좋다.’⁴²⁾라고 설명하고 있다. 『탕액본초(湯液本草)』(1289)에서는 ‘곽향은 방형(芳馨)한 기운이 있어 비장을 도와 막힌 위(胃)를 열어 주며 구토를 그치게 한다.’⁴³⁾라고 설명하고 있으며, 『본초강목』에서는 ‘촉초(蜀椒)는 형향(馨香)한 기운이 있다.’⁴⁴⁾라고 하였으며, 『경악전서(景岳全書)』(1624)에서는 ‘백지(白芷)·곽향(藿香)·모향(茅香)·향부자(香附子)·방풍(防風)·목향(木香)·감초(甘草) 등은 형향(馨香)한 약재이다. 혈기는 좋은 향기[香]를 맡으면 순행하고 악취[臭]를 맡으면 역행한다.’⁴⁵⁾라고 설명하고 있다. 즉 기존 의학에서는 태음인 약재인 백지(白芷)를 제외하고 소양인 약재인 방풍(防風)과 대부분의 소음인 약재에서 향기가 나는 것을 ‘형향(馨香)’, ‘방형(芳馨)’이라고 표현하였다. 따라서 사상의학에서는 기존의 표현인 형향(馨香), 방형(芳馨) 대신 태음인 약재의 특성을 감안하여 ‘형(馨)’이라고 표현한 듯하다.

3) 호흡출납(呼吸出納)

사상의학에서 생리론(生理論)이라 할 수 있는 것은 수곡지기(水穀之氣)와 기액지기(氣液之氣)의 대사이다. 『사상초본권』에서는 ‘곡도(穀道: 대장과 항문)는 장위(腸胃)와 통하는데 온냉(溫冷)이 상하로 서로 이루어지고, 기도(氣道: 기관과 기관지)는 삼초(三焦)와 통하는데 허실(虛實)은 표리(表裏)에서 고르게 맞추어진다.’⁴⁶⁾라고 하여 수곡지기와 기액지기는 사람이 먹고 숨을 쉬는 기초적인 대사라고 설명하였다.

이는 뒤에 더욱 발전하여 『동의수세보원』에 ‘폐(肺)는 기액(氣液)을 내뿜고[呼], 간(肝)은 기액을 빨아들이므로[吸], 간(肝)과 폐(肺)는 기액을 호흡하는 문호(門戶: 드나드는 문)가 된다. 비(脾)는 음식물[水穀]을 받아들이고[納], 신(腎)은 음식물을 내보내는[出] 역할을 하므로 신(腎)과 비(脾)는 음식물을 출납(出納)하는 부고(府庫)가 된다.’⁴⁷⁾라고 하

42) 賈思勰, 『齊民要術』, 「橘」, 異物志曰 橘樹白花而赤實皮馨香 又有善味 江南有之 不生他所

43) 王好古, 『湯液本草』, 「藿香」, 心云 芳馨之氣 助脾開胃止嘔

44) 李時珍, 『本草綱目』, 「蜀椒」, 訣云 椒稟五行之氣而生 葉青皮紅花黃膜白子黑 其氣馨香 其性下行 能使火熱下達不致 上薰芳草之中功 皆不及

45) 張介賓, 『景岳全書』, 「集香散」 洗癰疽潰爛 白芷 藿香 茅香 香附 防風 木香 甘草 右用水三碗煎 數沸去粗 淋洗患處 立齋曰 此乃馨香之劑也 血氣聞香則行 得臭則逆也

46) 李濟馬, 『四象草本卷』, 穀道 通於腸胃 溫冷 交濟於上下 氣道 通於三焦 虛實 均適於表裏

47) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 肺以呼 肝以吸 肝肺者 呼吸氣液之門戶也 脾以納 腎以出 腎脾者 出納水穀之府庫也.

였다. 이를 다르게 표현하면 ‘수곡이 위(胃)로 들어오면 비(脾)가 호위하고, 수곡이 대장(大腸)으로 나가면 신(腎)이 호위하니, 비(脾)와 신(腎)은 수곡(水穀)을 출납(出納)하는 부고(府庫: 창고)가 되고 비(脾)와 신(腎)은 번갈아 보사(補瀉)한다. 기액은 위완(胃脘)에서 내뿜으면 폐(肺)가 호위하고, 기액을 소장(小腸)에서 빨아들이면 간(肝)이 호위하니 폐(肺)와 간(肝)은 기액을 호흡하는 문호(門戶)가 되고 폐(肺)와 간(肝)은 번갈아 가며 진퇴(進退)한다.’⁴⁸⁾라고 표현할 수도 있다. 따라서 태양인의 경우 기액을 내뿜고 흡어 주는 기운이 너무 강해지고 빨아들여 모으는 기운이 너무 약해지면 열격반위(噎膈反胃) 같은 태양인 리증이 생기고,⁴⁹⁾ 태음인은 태양인과 반대로 기액을 빨아들여 모으는 기운이 지나치게 강해지고 내뿜고 흡어 주는 기운이 너무 약하면 병에 걸리게 된다고 보았다. 이상을 정리하면 다음 <표 3>과 같다.

<표 3> 체질별 호흡출납(呼吸出納)

체질	편소지장	체질약	呼吸出納	대사 종류
태양인	肝小	肝藥	吸	氣液之氣
소양인	腎小	腎藥	出	水穀之氣
태음인	肺小	肺藥	呼	氣液之氣
소음인	脾小	脾藥	納	水穀之氣

4) 승강개합(升降開闔)

기존의 한의학에서는 약물이 작용하는 방향을 승강부침(升降浮沈)의 관점으로 말하였다. 승(升)은 상승(上升), 강(降)은 하강(下降), 부(浮)는 상행발산(上行發散), 침(沈)은 하행설리(下行泄痢)의 의미가 있다. 그러나 사상의학에서는 기존의 승강(升降) 개념은 소양인 소음인에게 해당되지만 태양인 태음인에게 있어서는 새로운 개념인 개합(開闔)으로 보았다.

태양인과 태음인을 내외(內外)의 관점으로 보면, 태양인은 겉으로 발산하기 쉽기 때문에 질병이 생기기 쉽고 태음인은 안으로 쌓이기 쉽기 때문에 질병이 생기기 쉽다. 소

48) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 水穀 納於胃而脾衛之 出於大腸而腎衛之 脾腎者 出納水穀之府庫 而迭爲補瀉者也 氣液 呼於胃脘而肺衛之 吸於小腸而肝衛之 肺肝者 呼吸氣液之門戶 而迭爲進退者也

49) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 太陽人 意強而操弱 意強則胃脘之氣 上達而呼散者 太過而越也 操弱則小腸之氣 中執而吸聚者 不支而餒也 所以其病 爲噎膈反胃也.

양인과 소음인은 상하(上下)의 관점으로 보면, 소양인은 위로 상승하는 기운이 많아 열이 생기고 소음인은 내려가는 기운이 많아 냉하기 쉽다. 따라서 『동무유고』에서 ‘태음인의 병은 닫히는 기운[闔氣]이 많고 열리는 기운[開氣]이 적기 때문에 생기고, 태양인의 병은 열리는 기운[開氣]이 많고 닫히는 기운[闔氣]이 적기 때문에 생기고, 소음인의 병은 내려가는 기운[降氣]이 많고 올라가는 기운[升氣]이 적기 때문에 생기고, 소양인의 병은 올라가는 기운[升氣]이 많고 내려가는 기운[降氣]이 적기 때문에 생긴다. 따라서 태음인에게는 우황(牛黃)·웅담(熊膽)·사향(麝香)·마황(麻黃)·행인(杏仁)·산약(山藥)·길경(桔梗)·황금(黃芩)·조각(皂角) 등과 같이 뚫고 나가는 힘[通力]이 좋은 약이 좋고, 태양인에게는 교맥(蕎麥)·포도(葡萄)·모과(木瓜)·황기(黃芪)·감초(甘草)·오가피(五加皮)·미후도(彌猴桃) 등과 같이 막는 힘[塞力]이 좋은 약이 좋고, 소음인에게는 관계(官桂)·부자(附子)·당귀(當歸)·천궁(川芎)·목향(木香)·진피(陳皮)·인삼·창출·녹용(鹿茸)·자하거(紫河車) 등과 같이 올리는 힘[升力]이 좋은 약이 좋고, 소양인에게는 석고(石膏)·황련(黃連)·택사(澤瀉)·지황(地黃)·황백(黃柏)·산수유(山茱萸)·구기자(枸杞子) 등과 같이 내리는 힘[降力]이 좋은 약이 좋은 것이다.’⁵⁰⁾라고 설명하고 있다. 참고로 여기에 언급된 황기(黃芪)와 감초(甘草)는 소음인에게 좋고, 녹용(鹿茸)은 태음인에게 좋은 것으로 후에 재분류된다.

『사상초본권(四象草本卷)』에서는 이를 달리 표현하여 ‘태음인 약은 밖으로 통하는 약[通外]이 마땅하고 중심을 지키는 약[固中]은 마땅하지 않으며, 소양인 약은 장의 열을 내리는 약[清腸]이 마땅하고 속을 따뜻하게 하는 약[溫裏]이 마땅하지 않으며, 태양인 약은 중심을 지키는 약[固中]이 마땅하고 밖으로 통하는 약[通外]이 마땅하지 않으며, 소음인 약은 속을 따뜻하게 하는 약[溫裏]이 마땅하고 장의 열을 내리는 약[清腸]이 마땅하지 않다.’⁵¹⁾라고 하여, 태양인에게는 중심을 지키는 약[固中], 태음인에게는 밖으로 통하는 약[通外], 소양인에게는 장의 열을 내리는 약[清腸], 소음인 약은 속을 따뜻하게 하는 약

50) 李濟馬, 『東武遺稿』, 肺之病 闔氣多而開氣少 故其藥宜通 而不宜塞也 牛黃 熊膽 麝香 麻黃 杏仁 山藥 桔梗 黃芩 皂角之類 通力有餘 故肺病之吉藥也 蕎麥 葡萄 木瓜 黃芪 甘草之類 塞力有餘 故肺病之凶藥也 肝之病 開氣多而闔氣少 故蕎麥 葡萄 黃芪 甘草 五加皮 彌猴桃之類 塞力有餘 故肝病之吉藥也 牛黃 麝香之類 通力有餘 故肝病之凶藥也 脾之病 降氣多而升氣少 故官桂 附子 當歸 川芎 木香 陳皮 蔘朮 鹿茸 紫河車之類 升力有餘 故脾病之吉藥也 石膏 黃連 澤瀉 山茱萸之類 降力有餘 故脾病之凶藥也 腎之病 升氣多而降氣少 故地黃 黃柏 山茱萸 枸杞子之類 降力有餘 故腎病之吉藥也 官桂 附子 蔘茸之類 升力有餘 故腎病之凶藥也.

51) 李濟馬, 『四象草本卷』, 太陰之藥 宜通外而不宜固中 少陽之藥 宜清腸而不宜溫裏 太陽之藥 宜固中不宜通外 少陰之藥 宜溫裏不宜清腸.

[溫裏]이 좋다고 하였다. 따라서 『동의수세보원』에서는 소음인은 기운을 올리고[升] 소양인은 기운을 내리며[降] 태음인은 멎쳐진 기운을 느슨하게 하고[緩] 태양인은 뻗치는 기운을 단속하여야[束] 한다는 승강완속(升降緩束)의 개념으로 정리하고 있다.⁵²⁾ 이상을 정리하면 <표 4>와 같다.

<표 4> 체질별 승강개합(升降開闔)

체질	편소지장	체질약					약 물
태양인	肝小	肝藥	闔	塞力	固中	束	蕎麥 葡萄 木瓜 五加皮 獼猴桃
소양인	腎小	腎藥	降	降力	清腸	降	石膏 黃連 澤瀉 地黃 黃柏 山茱萸 枸杞子
태음인	肺小	肺藥	開	通力	通外	緩	牛黃 熊膽 麝香 麻黃 杏仁 山藥 桔梗 黃芩 皂角
소음인	脾小	脾藥	升	升力	溫裏	升	官桂 附子 當歸 川芎 木香 陳皮 人參 蒼朮 紫河車

5) 평생 금해야 하는 것

『동의수세보원 갑오본』(1894)이 저술되고 개정 인쇄본인 『동의수세보원 초판본』(1901)이 출간되기 바로 직전에 저술된 저자 미상의 『보제연설(普濟演說)』(1900)은 사상 의학의 변화를 읽을 수 있는 귀중한 자료이다. 『보제연설』에서는 각 체질별로 평생 조심해야 할 약재를 다음과 같이 분류하였다.

‘소양인이 평생 조심해야 하는 것은 보기(補氣)하는 약과 소도(消導: 음식이 소화되도록 함)시키는 약재이다. 복통과 설사는 하강(下降)하는 병으로, 병이 들어 아프더라도 소양인에게 이런 병이 있으면 병이 나으려는 조짐이니 모름지기 깊이 염려할 필요는 없다. 두통·해수(咳嗽: 기침)·토혈·허한(虛汗: 식은땀)·음냉(飲冷: 차가운 것을 마심)은 상승하는 병증으로 병이 매우 중한 것이니 미리 약을 써서 치료하는 것이 좋다. 태음인이 평생 조심해야 하는 것은 온열(溫熱)한 약재와 설사시키는 약[眞墮之味]이다. 두통·해수·허한(虛汗)·토혈은 상승하는 병증으로 병이 들어 아프더라도 태음인이 이런 증상이 있으면 병이 나으려는 조짐이니 염려할 필요는 없다. 몽설(夢泄: 꿈을 꾸면서 사정함)·이질 설사는 하강(下降)하는 병으로 병이 매우 중한 것이니 미리 약을 써서 치료하

52) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 蓋針穴 亦有太少陰陽四象人 應用之穴 而必有升降緩束之妙 繫是不可不察 敬俟後之謹厚而好活人者.

는 것이 좋다. 소음인이 평생 조심해야 하는 것은 보음(補陰)하는 약과 하초(下焦)에 작용하는 약재이다. 태양인이 평생 조심해야 하는 것은 양기를 돋우는[助陽] 약과 상초(上焦)에 작용하는 약재이다.’⁵³⁾

『보제연설』의 분류 방법이 동무의 생각과 반드시 일치한다고는 할 수 없지만, 당시 의학계에서 사상의학을 어떻게 인식하고 약재를 분류했는지에 대한 단서를 볼 수 있다. 이상을 정리하면 <표 5>와 같다.

<표 5> 체질별 금기약

체질	편소지장	체질약	금기약
태양인	肝小	肝藥	助陽之藥 上焦之劑
소양인	腎小	腎藥	補氣之藥 消導之劑
태음인	肺小	肺藥	溫熱之劑 眞墮之味
소음인	脾小	脾藥	補陰之藥 下焦之劑

6) 온열양한(溫熱涼寒)

수곡(水穀)이 들어오고 나감과, 기액(氣液)이 내뿜고 흡수함에 따라 체질별 기운의 차이가 난다. 『동의수세보원』에 의하면 ‘태양인은 양온지기(陽溫之氣)가 많아지게 되고, 소양인은 양열지기(陽熱之氣)가 많아지게 되고, 태음인은 음량지기(陰涼之氣)가 많아지게 되고, 소음인은 음한지기(陰寒之氣)가 많아지게 된다.’⁵⁴⁾고 하였다. 그런데 소음인과 소양인은 한열의 개념으로 보아도 좋지만, 태양인과 태음인은 한열의 개념보다는 앞에

53) 『普濟演說』, 少陽人 怒心弘大 哀心促急 怒心弘大 則氣注脾而脾益盛 哀心促急 則氣注腎而腎益削 恒戒哀怒者 爲此也. 平生所忌者 補氣之藥 消導之劑也. 腹痛 泄瀉 下降之病也 病則病矣而有此 病愈之兆也 不須深慮 頭痛 咳嗽 吐血 虛汗 飲冷 上升之症也 病實重也 豫備藥治可也. 太陰人 喜心廣大 樂心促急 喜心廣大 則氣注肝而肝益盛 樂心促急 則氣挽肺而肺益削 恒戒喜樂者謂此也. 平生所忌 溫熱之劑 眞墮之味也. 頭痛 咳嗽 虛汗 吐血 上升之症也 病中有此 病愈之兆也 不須深慮 夢泄 痢疾 泄瀉 下降之症也 病實重也 豫備藥治可也. 少陰人 樂心深大 而喜心促急 樂心深大 則氣注腎而腎益盛 喜心促急 則氣消脾而脾益削 平生所忌者 補陰之藥 下焦之劑也 平生所戒者 喜心樂心也 東川之人乎. 太陽人 哀心弘大 怒心促急 哀心弘大 則氣注肺而肺益盛 怒心促急 則氣挽肝而肝益削 平生所戒者 哀心怒心也 平生所忌者 助陽之藥 上焦之劑也 沖齊之人乎

54) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 少陽人 大腸出水穀 陰寒之氣 不足 則胃中納水穀 陽熱之氣 必盛也 太陽人 小腸吸氣液 陰涼之氣 不足 則胃脘呼氣液 陽溫之氣 必盛也 胃脘陽溫之氣 太盛 則胃脘血液 乾枯 其勢固然也. 然非但乾枯而然也 上呼之氣 太過 而中吸之氣 太不支 故食物不吸入 而還呼出也.

서 언급했듯이 기운이 뻗치고 수렴하는 개념으로 접근해야 한다.

수곡(水穀)의 온열량한(溫熱涼寒)에 대한 개념은 ‘수곡(水穀)이 위(胃)에 머물렀을 때 훈증(薰蒸)되면 열기(熱氣)가 되고, 소장에서 소화될 때 평담(平淡)하면 양기(涼氣)가 되고, 열기중 경청(輕淸)한 것이 위완(胃脘)으로 상승하여 온기(溫氣)가 되고, 양기(涼氣)중 질중(質重)한 것이 대장(大腸)으로 내려가 한기(寒氣)가 된다.’⁵⁵⁾고 하여 음식이 소화되면서 나뉜다고 보았다. 즉 위완(胃脘)·위(胃)·소장(小腸)·대장(大腸) 등의 위치에 따라 온기·열기·양기·한기로 구분된다는 것이다. 이렇게 되는 까닭은 ‘위완(胃脘)이 입과 코로 통해 있기 때문에 수곡지기가 상승하고, 대장이 항문과 통해 있기 때문에 수곡지기가 하강한다. 위(胃)의 형상이 광대(廣大)하여 포용(包容)하기 때문에 수곡지기가 정축(停畜: 저장하여 쌓임)하는 것이고, 소장(小腸)의 형상이 협착(狹窄: 자리가 몹시 좁음)하고 굴곡(屈曲)하기 때문에 수곡지기가 소도(消導: 음식이 소화되도록 함)된다.’⁵⁶⁾라고 했다.

소양인과 소음인의 경우 왜 열(熱)과 한(寒)으로 되느냐에 대해 『사상초본권(四象草本卷)』에서 자문자답하기를 ‘수곡(水穀)이 장위(腸胃)로 들어가 소화되는 것은 같지만, 소양인의 몸은 항상 열(熱)로 병이 되고 소음인의 몸은 항상 한(寒)으로 병이 되는 것은 어떤 이유인가라고 자문하였다. 이에 자답하기를 소양인의 음식물을 받아들이는 위(胃)는 넓지만 내보내는 대장(大腸)은 좁다. 비유하면 항아리 속의 술이 숙성할 때 밀봉하면 열기가 쉽게 생기는 것과 같다. 소음인에게 있어서 음식물을 내보내는 대장은 넓지만 음식물을 받아들이는 위는 좁다. 비유하면 물이 고여 있는 샘에서 자꾸 물이 솟아오른다면 한기가 쉽게 생기는 것과 같다. 이런 까닭에 소양인은 대변을 하루에 두서너 차례 보면 더욱 좋고 소음인은 대변을 2~3일에 한 번 보아도 무방하다.’⁵⁷⁾라고 하여, 소양인은 열이 나고 소음인은 몸이 냉해진 이유를 항아리와 샘을 비유하여 설명하였다. 또 다시 비유하기를 ‘소양인은 곡식을 받아들이는 위(胃)의 기운은 넓지만 찌꺼기를 내보내는 대장과 방광의 기운은 좁다. 비유하면 술 빛는 항아리의 위아래를 꼭 막아 두면 열기가 저절

55) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 水穀 自胃脘而入于胃 自胃而入于小腸 自小腸而入于大腸 自大腸而出于肛門者 水穀之都數 停畜於胃 而薰蒸爲熱氣 消導於小腸 而平淡爲涼氣 熱氣之輕淸者 上升於胃脘 而爲溫氣 涼氣之質重者 下降於大腸 而爲寒氣.

56) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 『臟腑論』, 胃脘通於口鼻 故水穀之氣 上升也 大腸 通於肛門 故水穀之氣 下降也 胃之體 廣大而包容 故水穀之氣 停畜也 小腸之體 狹窄而屈曲 故水穀之氣 消導也.

57) 李濟馬, 『四象草本卷』, 問水穀之入于腸胃也 爲其所化一也 而少陽軀殼 常病于熱 少陰軀殼 常病于寒者 何也 曰少陽人 受穀之胃闊 而泄穀之大腸窄 譬如甕中酒釀 宿釀密封 則熱氣易生也 少陰人 泄穀之大腸潤 而受穀之胃窄 譬如停溜之水泉 生泉益來 則寒氣易生也 是故 少陽大便 一日數三次 益好 少陰大便 二三日一次 無妨

로 생기는 것과 같다. 소음인은 곡식을 받아들이는 위(胃)의 기운은 좁지만 찌꺼기를 내 보내는 대장과 방광의 기운은 넓다. 비유하면 물을 대 주는 샘에서 눈에 먼저 공급한 물이 이미 빠져나가고 새로 공급되는 물이 자꾸 들어오면 눈에 냉기가 저절로 생기는 것과 같다.’⁵⁸⁾라고 반복 설명하기도 하였다.

이제 태양인과 소양인에 대해 살펴보자. ‘소양인의 대장은 수곡(水穀)을 배출하는 데 음한(陰寒)한 기운이 부족하면 위(胃)로 들어오는 수곡에 양열(陽熱)한 기운이 반드시 많아지게 된다. 태양인의 소장(小腸)은 기액(氣液)을 흡취하는 데 있어서 음량(陰涼)한 기운이 부족하면 위완(胃脘)의 기액을 내뿜는 데 있어서 양온(陽溫)한 기운이 반드시 많아지게 된다.’⁵⁹⁾라고 하여 소양인이 양열지기(陽熱之氣)가 많아지고, 태양인은 양온지기(陽溫之氣)가 많아진다고 설명하였다. 그러나 태양인에게 양온지기(陽溫之氣)가 형성되는 과정에서 기액지기가 흡취와 발산의 기준으로 설명되고 있다. 따라서 소양인과 소음인은 수곡지기가 기준이 되지만 태음인과 태양인은 기액지기를 기준으로 해석하는 것이 타당하다.

기존 한의학에서는 사기(四氣: 寒熱溫涼)의 기준으로 약재나 식품을 분류했지만, 이는 소양인과 소음인에게 해당된다. 태음인과 태양인의 경우 새로운 개념인 기액지기의 관점에서 보기 때문에 기존 방식으로는 접근하기 어렵다.

7) 보명지주(保命之主)

보명지주(保命之主)는 ‘생명[命]을 유지하고 보존하는[保] 주된[主] 기운’이라는 뜻으로, 사상의학에서는 체질별로 다르다고 보고 있다. ‘태양인은 소장(小腸)과 간(肝)의 음량지기(陰涼之氣)를 흡취(吸聚)하는 것이 부족하면 위완(胃脘)과 폐(肺)의 양온지기(陽溫之氣)를 호산(呼散)하는 것이 많아지고, 태음인은 위완(胃脘)과 폐(肺)의 양온지기를 호산하는 것이 부족하면 소장(小腸)과 간(肝)의 음량지기(陰涼之氣)를 흡취하는 것이 많아진다. 소양인은 대장(大腸)과 신(腎)의 음한지기(陰寒之氣)를 출방(出放)하는 것이 부족하면 위(胃)와 비(脾)의 양열지기(陽熱之氣)를 납적(納積)하는 것이 많아지고, 소음인은 위(胃)와 비(脾)의 양열지기를 납적하는 것이 부족하면 대장(大腸)과 신(腎)의 음한지기를 출방(出放)하는 것이 많아진다. 따라서 태양인에게에는 흡취지기(吸聚之氣), 소양인에게에는

58) 李濟馬, 『四象草本卷』, 少陽人 受穀之胃氣闊 而出粕之大腸膀胱氣窄 比如釀酒之瓮上下緊封 熱氣自生 少陰人受穀胃氣窄 而出粕之大腸膀胱氣闊 而比如灌漑之泉 旧灌已泄 新灌壅全 冷氣自生也

59) 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 少陽人 大腸出水穀 陰寒之氣 不足 則胃中納水穀 陽熱之氣 必盛也 太陽人 小腸吸氣液 陰涼之氣 不足 則胃脘呼氣液 陽溫之氣 必盛也

음청지기(陰淸之氣), 태음인에게는 호산지기(呼散之氣), 소음인에게는 양난지기(陽煖之氣)가 보명지주(保命之主)가 되는 것이다.⁶⁰⁾라고 하여 보명지주가 체질별로 다르고, 이를 잘 지키는 것이 생명을 유지하는 기본이라고 하였다. 이상을 정리하면 <표 6>과 같다.

<표 6> 체질별 보명지주(保命之主)

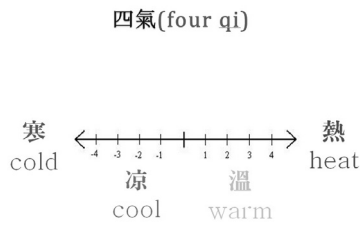
체질	편소지장	체질약	保命之主
태양인	肝小	肝藥	吸聚之氣
소양인	腎小	腎藥	陰淸之氣
태음인	肺小	肺藥	呼散之氣
소음인	脾小	脾藥	陽煖之氣

Ⅲ. 약재와 음식 고찰

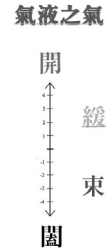
기존의 한의학에서는 약재나 음식에 대해 사기(四氣)와 오미(五味: 酸·苦·甘·辛·鹹)의 개념으로 보았다. 사기(四氣)라고 하지만, 차갑고[寒] 서늘한[涼] 것은 많이 차갑고 덜 차가운 차이일 뿐이며, 뜨겁고[熱] 따뜻한[溫] 것은 많이 뜨겁고 덜 뜨거운 차이일 뿐이다. 따라서 사기(四氣)는 한열의 차이로 이해되며 <그림 2>와 같이 1차원으로 해석되고 이는 수곡지기(水穀之氣)의 대사로 해석될 수 있다.

또한 약물이 작용하는 방향에 대하여 사상의학에서는 승강완속(升降緩束) 또는 승강개합(升降開闔)으로 표현하고 있는데, 이중 승강(升降)에 대한 개념은 소양인과 소음인에게 해당되므로 새로운 개념인 기액지기(氣液之氣)의 관점으로 보면 개합(開闔)과 완속(緩束)으로 볼 수 있다. 이를 더 상세히 살펴보면 <그림 3>과 같이 기액지기의 관점에서 많이 발산하는 것을 개(開), 발산은 하되 느슨하고 완만한 것을 완(緩), 수렴기운이 매우 강한 것을 합(闔), 약하게 수렴하는 것을 속(束)으로 볼 수 있다. 이들은 기준이 다른 1차원적인 관점으로 마치 x축과 y축의 기준으로 해석될 수 있다.

60) 李濟馬, 『東醫壽世保元 甲午本(舊本)』, 少陰人 以陽煖之氣 爲保命之主 故膻胃爲本 而膀胱大腸爲標也. 少陽人 以陰淸之氣 爲保命之主 故膀胱大腸爲本 而膻胃之爲標也. 太陰人 以呼散之氣 爲保命之主 故腦佳胃脘爲本 而腰脊小腸爲標 太陽人 以吸聚之氣 爲保命之主 故腰脊小腸爲本 而腦佳胃脘爲標.



<그림 2> 四氣



<그림 3>
氣液之氣

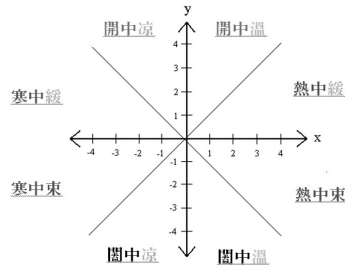
수곡지기(水穀之氣) 대사인 한열온량(寒熱溫涼)을 x축으로 놓고, 기액지기(氣液之氣) 대사인 개합완속(開闔緩束)을 y축으로 놓아 2차원의 개념으로 합성하여 보면 <그림 4>와 같이 된다.



<그림 4> 2차원

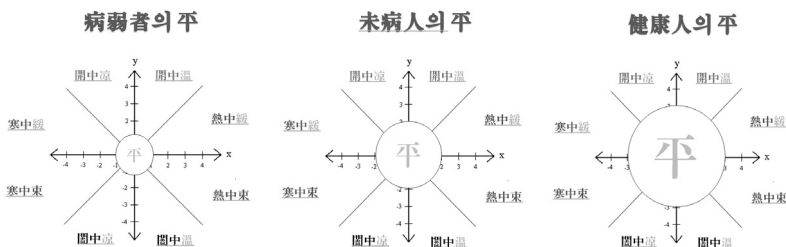
이러한 식으로 식품의 성질을 분류하고 $y=x$ 선과 $y=-x$ 선을 기준으로 종합적으로 살펴 보면 <그림 5>와 같이 열(熱)이 많은 식품이지만 약하게 발산(發散)하는 성질이 있는 경우[熱中緩]와, 약하게 수렴(收斂)하는 성질이 있는 경우[熱中束]가 있으며, 차가운[寒] 성질이 많은 식품이지만 약하게 발산(發散)하는 성질이 있는 경우[寒中緩]와, 약하게 수렴(收斂)하는 성질이 있는 경우[寒中束]가 있다. 또한 발산하는 성질이 강한 식품이지만 서늘한 기운이 있는 경우[開中涼]와 따뜻한 기운이 있는 경우[開中溫]가 있으며, 수렴하는 성질이 강한 식품이지만 서늘한 기운이 있는 식품[闔中涼]과 따뜻한 기운이 있는 경우[闔中溫]로 나눌 수 있다.

食品의 性質



<그림 5> 식품의 성질

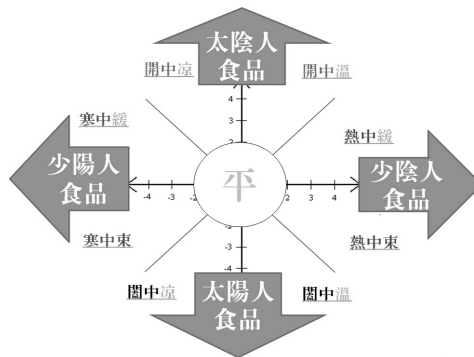
음식을 한열(寒熱)의 개념으로 보았을 때 거의 성질이 미미한 상태인 것이 있으며, 개합(開闔)의 개념으로 보았을 때 거의 성질이 미미한 상태의 것이 있다. 식품의 성질이 약하므로 체질과 무관하게 누구나 먹을 수 있으며, 인체에 큰 영향을 주지 않는 것을 평(平)의 개념으로 볼 수 있다. 즉 평(平)은 한열이나 수렴발산의 개념으로 보았을 때 매우 성질이 미약하여 어느 곳에도 치우치지 않는다는 의미이다. 그러나 같은 음식이라 하여도 병약자와 건강인에 따라 평(平)의 개념이 다를 수 있다. 즉 <그림 6>에 보이듯이 병약자(病弱者)의 경우 평(平)의 범위가 매우 작으나, <그림 7>과 같이 미병인(未病人)의 평(平)은 병약자(病弱者)에 비하여 더 크고, <그림 8>과 같이 건강인(健康人)의 평(平)은 상대적으로 제일 크다고 볼 수 있다. 즉 식품의 평(平)에 대한 범위가 병약자(病弱者) 미병인(未病人) 건강인(健康人)에 따라 다르다고 보기 때문에, 같은 음식이라 하여도 건강인(健康人)이 복용하면 무난하나 병약자(病弱者)나 미병인(未病人)의 경우는 음식의 성질이 신체에 영향을 미치는 경우가 발생할 수 있다.



<그림 6> 病弱者의 平 <그림 7> 未病人의 平 <그림 8> 健康人の 平

평(平)의 범위를 넘어가는 식품을 체질에 맞추어 어떻게 복용하는 것이 좋을까? <그림 9>에 보이듯이 발산하는 식품은 대부분 태음인에게 좋지만 서늘한 기운[開中涼]이 있는 경우 일정 부분 소양인에게 좋은 식품으로 볼 수도 있으며, 따뜻한 기운[開中溫]이 있는 경우 일정 부분 소음인에게 좋은 식품으로 볼 수도 있다. 수렴하는 식품은 대부분 태양인에게 좋지만 서늘한 기운[闔中涼]이 있는 경우 일정 부분 소양인에게 좋은 식품으로 볼 수 있으며, 따뜻한 기운[闔中溫]이 있는 경우 일정 부분 소음인에게 좋은 식품으로 볼 수도 있다.

마찬가지로 열(熱)이 많은 식품은 대부분 소음인에게 좋지만 발산(發散)하는 성질[熱中緩]이 있는 경우 일정 부분 태음인에게 좋은 식품으로 볼 수 있으며, 수렴(收斂)하는 성질[熱中束]이 있는 경우 일정 부분 태양인에게 좋은 식품으로 볼 수 있다. 차가운[寒] 성질이 많은 식품은 대부분 소양인에게 좋지만 발산(發散)하는 성질[寒中緩]이 있는 경우 일정 부분 태음인에게 좋은 식품으로 볼 수도 있으며, 수렴(收斂)하는 성질[寒中束]이 있는 경우 일정 부분 태양인에게 좋은 식품으로 볼 수 있다.



<그림 9> 체질별 식품

IV. 결 론

1. 중국에서는 식치(食治)의 중요성을 예전부터 인식하여 식의(食醫)를 제도적으로 만들었고, 우리나라에서도 이를 인식하여 식의 제도가 있었다. 음식 섭생으로 정(精)을

기르는 것을 중시하였으며, 약재를 사용하여 질병의 상당 부분을 치료하지만, 치료되지 않고 남은 질병은 음식으로 다스렸다.

2. 사상의학에서 편소지장(偏小之臟)의 본상지기(本常之氣)에 따라 명맥(命脈)이 결정되므로, 편소지장을 생식(生息)하고 충보(充補)하는 것이 중요하다. 본상지기를 회복하는 데 있어서 약의 기운에 의존하지 말고 장(臟)의 기운을 북돋우는 데 중점을 두어야 한다. 또한 본상지기를 유지하기 위해 음식을 먹지만 과식하지 말아야 한다.

3. 넓은 의미에서는 사상식품은 사상약물에 포함되지만 좁은 의미로는 사상식품과 사상약물은 서로 다르다. 편소지장의 본상지기를 해칠 수 있는 것이 사상약물이며, 본상지기를 해치지 않고 오히려 자양하는 것이 사상식품이다. 또한 약물과 식품의 차이는 맛과 식감의 유무이고, 성질이 부드럽고 강함과, 장복(長服)과 단복(短服)의 차이이다. 그리고 부작용의 정도 차이가 있다. 그러나 약물과 식품을 정확하게 구분하기 어렵고 이를 혼용하여 사용하기도 한다.

4. 사상식품 분류 기준을 정리하면 다음과 같다.

태양인은 편소지장인 간(肝)의 본상지기를 도와주는 간약(肝藥)이 좋다. 액(液)이 많은 메밀·포도·모과 등이 이에 속하며, 기액지기(氣液之氣)를 흡(吸)하는 것이다. 그리고 합(闔)·색력(塞力)·고중(固中)·속(束) 등으로 그 속성을 표현하기도 하였다. 태양인의 금기는 조양(助陽: 양기를 돋움)하는 약과 상초(上焦)에 작용하는 약재이다.

소양인은 편소지장인 신(腎)의 본상지기를 도와주는 신약(腎藥)이 좋다. 미(味)가 많은 황백·목통·산수유 등이 이에 속하며, 수곡지기를 출(出)하는 것이다. 그리고 강력(降力)·청장(淸腸) 등으로 그 속성을 표현하기도 하였다. 소양인의 금기는 보기(補氣)하는 약과 소도(消導)시키는 약재이다.

태음인은 편소지장인 폐(肺)의 본상지기를 도와주는 폐약(肺藥)이 좋다. 형(馨)이 많은 맥문동·오미자·석창포 등이 이에 속하며, 기액지기(氣液之氣)를 호(呼)하는 것이다. 개(開)·통력(通力)·통외(通外)·완(緩) 등으로 그 속성을 표현하기도 하였다. 태음인의 금기는 온열(溫熱)한 약재와 설사시키는 약[眞鹽之味]이다.

소음인은 편소지장인 비(脾)의 본상지기를 도와주는 비약(脾藥)이 좋다. 취(臭)가 많은 관계·부자·백출·당귀 등이 이에 속하며, 수곡지기를 납(納)하는 것이다. 승력(升力)·온리(溫裏) 등으로 그 속성을 표현하기도 하였다. 소음인의 금기는 보음(補陰)하는 약과 하초(下焦)에 작용하는 약재이다.

5. 생명[命]을 유지하고 보존하는[保] 주된[主] 기운인 보명지주(保命之主)는 태양인

에게는 흡취지기(吸聚之氣), 소양인에게는 음청지기(陰淸之氣), 태음인에게는 호산지기(呼散之氣), 소음인에게는 양난지기(陽煖之氣)이다.

6. 사기(四氣: 寒熱溫涼)와 오미(五味: 酸·苦·甘·辛·鹹의 5가지 맛)로 식품을 분류하는 기존 방법은 1차원에 해당되어 수곡지기를 중시하는 소양인 약과 소음인 약을 해석하는 데 유리하나 기액지기를 중시하는 태양인 약과 태음인 약을 해석하는 데 한계가 있다. 이에 한열의 편차를 중시하는 수곡지기 대사와 발산과 수렴을 중시하는 기액지기 대사를 동시에 고려하는 2차원 관점으로 식품을 보아야 한다. 따라서 열(熱)이 많은 식품이지만 발산(發散)하는 기운[熱中緩]과 수렴(收斂)하는 기운[熱中束]이 있으며, 차가운[寒] 성질이 많은 식품이지만 발산(發散)하는 기운[寒中緩]과 수렴(收斂)하는 기운[寒中束]이 있다. 또한 발산하는 성질이 강하지만 서늘한 기운이 있는 식품[開中涼]과 따뜻한 기운[開中溫]이 있는 식품이 있으며, 수렴하는 성질이 강하지만 서늘한 기운[闔中涼]이 있는 식품과 따뜻한 기운[闔中溫]이 있는 식품이 있다.

7. 체질에 상관없이 복용할 수 있으며 크게 영향을 주지 않는 식품에서의 평(平)의 개념은 병약자(病弱者) 미병인(未病人) 건강인(健康人)에 따라 다르다고 볼 수 있으므로 같은 음식이라 하여도 건강인(健康人)이 복용하면 무난하나 병약자(病弱者)나 미병인(未病人)의 경우는 음식의 성질이 신체에 영향을 미치는 경우가 발생할 수 있다.

참고문헌

- 賈思勰, 『齊民要術』, 文淵閣四庫全書 730冊, 驪江出版社.
- 紀昀, 『周禮集說』, 文淵閣四庫全書, 驪江出版社, 1988.
- 董斯張, 『廣博物志』, 文淵閣四庫全書, 驪江出版社, 1988.
- 王冰次注, 『黃帝內經素問』, 中國醫學大系 1卷, 驪江出版社. 1988.
- 王安石, 『周官新義』, 文淵閣四庫全書, 驪江出版社, 1988.
- 王好古, 『湯液本草』, 中國醫學大系 13卷, 驪江出版社. 1988.
- 李時珍, 『本草綱目』, 中國醫學大系 40-42卷, 驪江出版社, 1988.
- 李濟馬, 『東醫壽世保元』, 韓國醫學大系 42卷, 驪江出版社. 1988.
- 李濟馬, 『四象草本卷』, 慶熙大學校 韓醫科大學 四象體質科.
- 張介賓, 『景岳全書』, 中國醫學大系 45~46卷, 驪江出版社, 1988.
- 張介賓, 『類經』, 中國醫學大系 44卷, 驪江出版社, 1988.
- 全循義, 『食療纂要』
- 朱申, 『周禮句解』, 文淵閣四庫全書, 驪江出版社, 1988.
- 陳直, 『壽親養老新書』, 中國醫學大系 6卷, 驪江出版社, 1988.
- 『普濟演說』,
- 『朝鮮王朝實錄』,
- 『周禮注疏』, 文淵閣四庫全書, 驪江出版社, 1988.

Literature on Food Cure and Diet Therapy depending on Sasang Constitutional Medicine

Kim Jong-Dug

Abstract

The results of this study are as follows.

First, the old Chinese had a dietary specialist recognizing the importance of food cure as Koreans did. They highly regarded Jeong(精) with diet therapy as curing a large part of the disease by medicinal herb and the last part of the disease by food.

Second, according to Sasang Constitutional Medicine, as life(命脈) depends on the original Qi of Pyeonsojisang, living and breathing(生息) and supplementation(充補) is crucial for Pyeonsojisang(偏小之臟). To recover the original Qi, encouraging the Qi of Jang(臟) should be done rather than depending on the power of medicine. In addition, not overeating but eating properly is important to stay the Original Qi.

Third, in a broad sense, Sasang food is included in Sasang Medicinal herbs while in a narrow sense, Sasang food is different from Sasang Medicinal herbs. Sasang Medicinal herbs may make the original Qi of Pyeonsojijang ruined whereas Sasang food can make the original Qi nourished. Also, the difference between Medicinal food and Sasang food is taste, chewy texture, tenderness or chewiness, constant or short use of them, and the degree of side effects. Still, medicinal herb and food are hard to distinguished exactly but used mixed with one another.

Forth, the standard of classification for Sasang foods are summarized as mentioned below.

Medicinal food for liver called Ganyak, Taeyang-in's Pyeonsojijang, is good for Taeyang-in. Grapes, buckwheat, quince, which have much liquid(液) and suck in Qi and Fluid Metabolism, belong to Medicinal food for liver. The quality is expressed in hap(闔), Saekryek(塞力), Gojung(固中), Sok(束) etc. The taboo of Taeyang-in is the medicinal herbs

helping Yang Qi raised and affecting Sangcho(上焦).

Medicinal herbs which help the original Qi of kidneys(腎) called Shinyak are good for Soyang-in. Hawangbak, Moktong, Sansuyu etc. having lots of Mi(味) belong to Shinyak, which makes Sugokji-Qi(水穀之氣) go out(出). The quality of Shinyak is expressed in Gangryek(降力), Cheongjang(清腸) etc. The taboo of Soyang-in is the medicinal herbs like Bo-Qi(補氣) and So-Do(消導).

Medicinal herbs which help the original Qi of lungs(肺) called Pyeyak(肺藥) are good for Tae-eumin. Liriope rhizome, fruit of Maximowiczia typica, a sweet flag etc. having much hyeong(馨) belong to Pyeyak, which help Qiaekji-Qi exhaled(呼). The quality of Pyeyak is expressed in Gae(開), Tongryek(通力), Tongoi(通外), wan(緩), etc. The taboo of Tae-eumin is the medicinal herbs which have onyel(溫熱) and cause diarrhea[眞墮之味].

Medicinal herbs which help the original Qi of spleen(脾) called Biyak(脾藥) are good for Soeum-in. Buja, white atractylis, Korean angelica root having much chui(臭) belong to Biyak which accepting(納) Sugokji-Qi(水穀之氣). The quality of Biyak is expressed in Seungreyk(升力), Onri(溫裏) etc. The taboo of Soeum-in is the medicinal herbs which have Boeum(補陰) and affect hacho(下焦).

Fifth, Bomyeongjiju(保命之主), which is keeping and preserving the life[命], is Heupchuiji-Qi(吸聚之氣) for Taeyang-in, Eumcheongji-Qi(陰清之氣) for Soyang-in, Hosanji-Qi(呼散之氣) for Tae-eumin, Yangnanji-Qi(陽煖之氣) for Soeum-in.

Sixth, the four Qi(四氣, 寒熱溫涼) and the five flavors(五味, 酸苦甘辛鹹) as the standard of classification for foods are limited to one-dimension, which has the advantage of explaining the medicinal herbs of Soyang-in and So-eumin focusing on Suaekji-Qi but the disadvantage of explaining the medicinal herbs of Taeyang-in and Ta-eumin focusing on Giaekji-Qi. Therefore, both Sugokjigidaesa which considers Hanyel and Giaekjigidaesa which considers inhaling and exhaling should be understood in the two dimensional viewpoint. Food having yel(熱) possibly has the trait of either exhaling(發散) [熱中緩] or inhaling(收斂) [熱中束] and the food having the cold[寒] possibly has the trait of either exhaling[寒中緩] or inhaling[寒中束]. Also, food having the trait of exhaling possibly has the trait of either the cool[開中涼] or the warmth[闔中溫].

Keywords : food cure(食治), diet therapy depending on Sasang Constitution,
the original Qi(本常之氣)